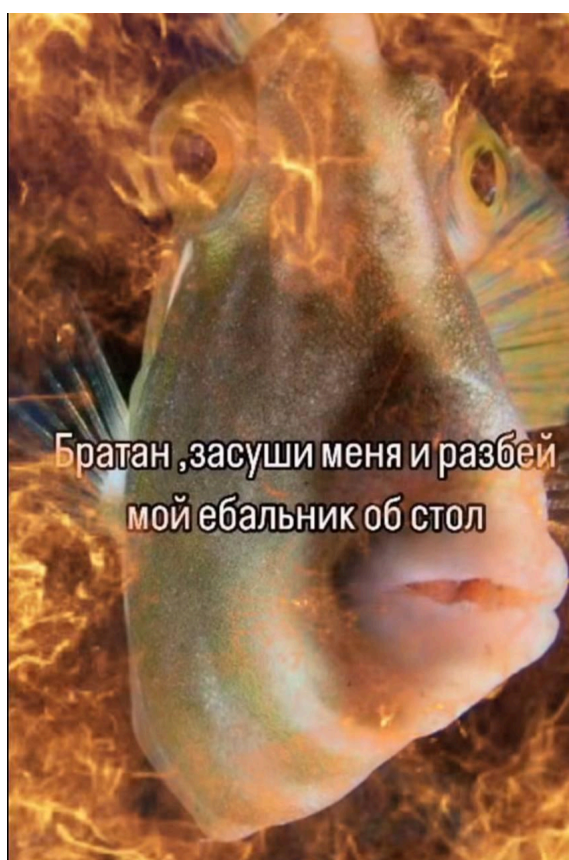


Поликлиническая практика

Файл сделан из любви и из страсти:

**Ботнарюк Александра❤️; Лобнева Жанна🌹; Пестова Елизавета
👍; Момировска Яна; Торбунова Екатерина; Дарья Салмохвалова**



Амбулаторные карты

1.1 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями гриппа, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности

Возраст и пол: мужчина, 35 лет

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы: на внезапное появление озноба, повышение температуры до 39 С, сильную головную боль, слабость, снижение аппетита, насморк, ломота в мышцах и суставах, дискомфорт при движении глазных яблок, чувство «саднения» за грудиной и сухой кашель.

Анамнез заболевания: со слов пациента вчера вечером внезапно ощутил озноб, температура тела повысилась до 39 С, позже присоединились головная боль, слабость, снижение аппетита, насморк, ломота в мышцах и суставах, дискомфорт при движении глазных яблок, чувство «саднения» за грудиной и сухой кашель. Известно, что 3 дня назад у нескольких коллег на работе отмечались схожие симптомы. Принимал «парацетамол» с последующим облегчением состояния на несколько часов. В связи с отсутствием положительной динамики обратился в поликлинику к врачу-терапевту с целью получения лечения.

Анамнез жизни: Рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: ветряная оспа в детстве. Вредные привычки: отрицает. Травмы, операции, гемотрансфузии: отрицает. Прием лекарственных препаратов: отрицает. Наследственность: неотягощена.

Аллергологический анамнез: неотягощен

Эпидемиологический анамнез: Выезд за пределы РФ последние 2 недели: отрицает. Контакт с инфекционными больными, больными ОРВИ и гриппом, лихорадящими больными за последние 2 недели: 3 дня назад у коллег на работе отмечались симптомы ОРВИ. Вакцинация от гриппа: **нет**.

Физикальный осмотр: Температура: 38,6 °С. Рост: 170 см, масса тела: 72 кг, ИМТ: 24,9 кг/м². Общее состояние: средней степени тяжести. Сознание: ясное. Положение: активное. Телосложение: нормостеническое. Кожные покровы (цвет, влажность, тургор): кожа лица гиперемирована. Тургор в норме. Сыпь: нет. Видимые слизистые: гиперемированы, влажные, инъекция сосудов склер. Отеки: нет. Зев и небные дужки: гиперемированы. Миндалины: без налета. Периферические лимфатические узлы: не увеличены.

Костно-мышечная система: Боли в мышцах, суставах.

Система органов дыхания: дыхание носом затруднено. ЧДД 24/мин. SpO₂ — 97%. Грудная клетка правильной формы, при пальпации безболезненна, голосовое дрожание не изменено, в акте дыхания вспомогательные мышцы не участвуют, дистанционные хрипы не слышны. Одышка: нет. Перкуторно: звук ясный лёгочный. Аускультативно: дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Хрипы: нет

Сердечно-сосудистая система: АД 110/70 мм рт/ст. ЧСС: 90уд/мин. Пульс ритмичный, симметричный, удовлетворительного напряжения и наполнения. Сердечные тоны ясные ритмичные. Патологические шумы не выслушиваются

Система органов пищеварения: Язык чистый, влажный. Живот не увеличен, симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания, при пальпации безболезненный, симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Печень не увеличена, край печени эластичный, ровный, безболезненный. Селезёнка не увеличена. Стул: регулярный, оформленный, без патологических примесей

Мочевыделительная система: Симптом поколачивания отрицательный. Мочеиспускание свободное, безболезненное

Нервная система и органы чувств: Менингеальные симптомы отрицательные. Очаговой неврологической симптоматики нет

Предварительный диагноз: Грипп, ринофаринготрахеит, типичное течение, средней степени тяжести, период разгара, неосложненный

Режим: амбулаторный

План обследования:

1. **Лабораторные:** Общий (клинический) анализ крови; Общий (клинический) анализ мочи; Экспресс-ИХА на АГ гриппа А, В, ОРВИ в мазках со слизистой; При отрицательном экспресс- тесте и подозрении на грипп- ПЦР на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ в назофарингеальных мазках
2. **Инструментальные:** Пульсоксиметрия

План лечения:

1. **Немедикаментозные методы лечения:** Диета: сбалансированное, легкоусвояемое питание; Обильное теплое питьё до 2-х литров в сутки (щелочная минеральная вода, отвар шиповника, чай, морсы и др.)
2. **Медикаментозные методы лечения:** *Осельтамивир внутрь по 75 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней; парацетамол перорально по 1-2 табл. (500- 1000 мг) до 4 раз в сутки при температуре выше 38 С; Ингаляции NaCl 0,9% через небулайзер 2-3 раза в день; Нафазолин – интраназально (в каждый носовой ход) по 1–3 капли 0,05% раствора 3–4 раза в сутки не более 5 дней*

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с «14.07.2026» по «20.07.2026»

Явка: 20.07.2026

1.2 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями аденовирусной инфекции, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина, 35 лет

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы: на постепенное повышение температуры тела до 38-39 °С, сопровождающееся вялостью, ухудшением аппетита, затруднением носового дыхания, насморком, болью в горле при глотании, жжением и ощущением песка в правом глазу

Анамнез заболевания: со слов пациента заболел 2 дня назад, когда отметил повышение температуры тела до 39 °С, снижение работоспособности, ухудшением аппетита, затруднение носового дыхания, насморк и боль в горле при глотании. Сегодня утром присоединились жжение и ощущение песка в правом глазу. Принимал препарат «Нурофен» без значимого улучшения состояния. В связи с отсутствием положительной динамики обратился в поликлинику к врачу-терапевту с целью получения лечения.

Анамнез жизни: Рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: ветряная оспа в детстве. Вредные привычки: отрицает. Травмы, операции, гемотрансфузии: отрицает. Прием лекарственных препаратов: отрицает. Наследственность: неотягощена.

Аллергологический анамнез: неотягощен

Эпидемиологический анамнез: Выезд за пределы РФ последние 2 недели: отрицает. Контакт с инфекционными больными, больными ОРВИ и гриппом, лихорадящими больными за последние 2 недели: отрицает.

Физикальный осмотр: Температура: 38,6 °С. Рост: 170 см, масса тела: 72 кг, ИМТ: 24,9 кг/м². Общее состояние: средней степени тяжести. Сознание: ясное. Положение: активное. Телосложение: нормостеническое. Кожные покровы (цвет, влажность, тургор):

физиологической окраски. Тургор в норме. Сыпь: нет. Видимые слизистые: гиперемированы, влажные, инъекция сосудов склер. Конъюнктивит: справа гиперемирована, зерниста, визуализируются точечные кровоизлияния, несколько набухшая, отмечается слезотечение. Отеки: нет. Зев и небные дужки: гиперемированы. Миндалины: увеличены, гиперемированы, без налета. Периферические лимфатические узлы: шейные, поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены.

Костно-мышечная система: Походка и поза в норме. Боли в мышцах, суставах, костях: нет. Деформации костей, суставов: нет. Объем движений в суставах: в норме.

Система органов дыхания: дыхание носом затруднено. ЧДД 22/мин. SpO₂ — 97%. Грудная клетка правильной формы, при пальпации безболезненна, голосовое дрожание не изменено, в акте дыхания вспомогательные мышцы не участвуют, дистанционные хрипы не слышны. Одышка: нет. Перкуторно: звук ясный лёгочный. Аускультативно: дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Хрипы: нет

Сердечно-сосудистая система: АД 100/70 мм рт/ст. ЧСС: 65 уд/мин. Пульс ритмичный, симметричный, удовлетворительного напряжения и наполнения. Сердечные тоны ясные ритмичные. Патологические шумы не выслушиваются

Система органов пищеварения: Язык чистый, влажный. Живот не увеличен, симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания, при пальпации безболезненный, симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Печень не увеличена, край печени эластичный, ровный, безболезненный. Селезёнка не увеличена. Стул: регулярный, оформленный, без патологических примесей

Мочевыделительная система: Симптом поколачивания отрицательный. Мочеиспускание свободное, безболезненное

Нервная система и органы чувств: Менингеальные симптомы отрицательные. Очаговой неврологической симптоматики нет

Предварительный диагноз: Аденовирусная инфекция, фарингоконъюнктивальная лихорадка, типичное течение, средняя степень тяжести, период разгара, неосложненная

Режим: амбулаторный

План обследования:

1. **Лабораторные:** Общий (клинический) анализ крови; Общий (клинический) анализ мочи; Экспресс-ИХА на АГ гриппа А, В, ОРВИ в мазках со слизистой; При отрицательном экспресс- тесте и подозрении на грипп- ПЦР на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ в назофарингеальных мазках
2. **Инструментальные:** Пульсоксиметрия
3. Консультация врача-офтальмолога

План лечения:

1. **Немедикаментозные методы лечения:** Диета: сбалансированное, легкоусвояемое питание; Обильное теплое питье до 2-х литров в сутки (щелочная минеральная вода, отвар шиповника, чай, морсы и др.)
2. **Медикаментозные методы лечения:** Умифеновир *внутри до приема пищи по 200 мг 4 раза в сутки в течение 5 дней*; Ибупрофен перорально по 200–400 мг 3–4 раза в в течение 3–10 дней (максимальная суточная доза – 1200 мг) при температуре выше 38 С; Нафазолин – интраназально (в каждый носовой ход) по 1–3 капли 0,05% раствора 3–4 раза в сутки не более 5 дней; Офталмоферон (интерферон альфа-2b + дифенгидрамин) — по 1-2 капли в здоровый глаз (сначала), затем в больной глаз 6-8 раз в сутки в первые 2 дня, затем 3-4 раза/сут до улучшения

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с «14.07.2026» по «20.07.2026»

Явка: 20.07.2026

1.3 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями острого лакунарного тонзиллита, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина, 35 лет

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы: на сильную боль в горле при глотании, озноб и повышение температуры до 39 С, интенсивную головную боль и отсутствие аппетита .

Анамнез заболевания: со слов пациента 4 дня назад ощутил боль в горле при глотании, температура тела повысилась до 39 С, позже присоединились головная боль, слабость, снижение аппетита. Принимал «парацетамол», местно спрей «Ангидак форте» без значительного улучшения . В связи с отсутствием положительной динамики обратился в поликлинику к врачу-терапевту с целью получения лечения.

Анамнез жизни: Рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: ветряная оспа в детстве. Вредные привычки: отрицает. Травмы, операции, гемотрансфузии: отрицает. Прием лекарственных препаратов: отрицает. Наследственность: неотягощена.

Аллергологический анамнез: неотягощен

Эпидемиологический анамнез: Выезд за пределы РФ последние 2 недели: отрицает. Контакт с инфекционными больными, больными ОРВИ и гриппом, лихорадящими больными за последние 2 недели: отрицает.

Физикальный осмотр: Температура: 38,6 °С. Рост: 170 см, масса тела: 72 кг, ИМТ: 24,9 кг/м². Общее состояние: средней степени тяжести. Сознание: ясное. Положение: активное. Телосложение: нормостеническое. Кожные покровы (цвет, влажность, тургор): физиологической окраски. Тургор в норме. Сыпь: нет. Видимые слизистые: влажные. Отеки: нет. Зев и небные дужки: **яркая гиперемия слизистой оболочки задней стенки глотки**. Миндалины: **выраженная гиперемия и увеличение миндалин с двух сторон, желтовато-белые налеты, распространяющиеся из лакун по поверхности миндалин, легко снимаются шпателем, не оставляют кровоточащего дефекта**. Периферические лимфатические узлы: **регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны, не спаяны с окружающими тканями, подвижны, мягко эластичной консистенции**.

Костно-мышечная система: Походка и поза в норме. Боли в мышцах, суставах, костях: нет. Деформации костей, суставов: нет. Объем движений в суставах: в норме.

Система органов дыхания: свободное. ЧДД 24/мин. SpO₂ — 97%. Грудная клетка правильной формы, при пальпации безболезненна, голосовое дрожание не изменено, в акте дыхания вспомогательные мышцы не участвуют, дистанционные хрипы не слышны. Одышка: нет. Перкуторно: звук ясный легочный. Аускультативно: дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Хрипы: нет

Сердечно-сосудистая система: АД 120/80 мм рт/ст. ЧСС: 80 уд/мин. Пульс ритмичный, симметричный, удовлетворительного напряжения и наполнения. Сердечные тоны ясные ритмичные. Патологические шумы не выслушиваются

Система органов пищеварения: Язык влажный, есть налет. Живот не увеличен, симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания, при пальпации безболезненный, симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Печень не увеличена, край печени эластичный, ровный, безболезненный. Селезенка не увеличена. Стул: регулярный, оформленный, без патологических примесей

Мочевыделительная система: Симптом поколачивания отрицательный. Мочеиспускание свободное, безболезненное

Нервная система и органы чувств: Менингеальные симптомы отрицательные. Очаговой неврологической симптоматики нет

Предварительный диагноз: Острый тонзиллофарингит, лакунарная форма, средней степени тяжести, неосложненный (предположительно стрептококковой этиологии)

Режим: амбулаторный

План обследования:

1. **Лабораторные:** Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А, STREPTATEST (до начала антибактериальной терапии)

План лечения:

1. **Немедикаментозные методы лечения:** Диета: Ограничение раздражающей пищи (острое, кислое, соленое, горячее, холодное и т.д), при этом пища должна иметь мягкую консистенцию; Обильное теплое питье
2. **Медикаментозные методы лечения:** Амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки 10 дней независимо от приема пищи; Ибупрофен перорально по 200–400 мг 3–4 раза в течение 3–10 дней (максимальная суточная доза – 1200 мг) при температуре выше 38 С; Гексорал таб Экспресс таблетки для рассасывания (бензокаин+ хлоргексидина дигидрохлорид) по 1 таблетке каждые 1-2 часа по необходимости, но не более 8 таблеток в сутки, медленно рассасывать во рту до полного растворения

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с «14.07.2026» по «23.07.2026»

Явка: 23.07.2026

1.4 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями острого бронхита, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику

ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина, 35 лет

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы: на влажный кашель, надсадный, с небольшим отделением слизистой мокроты, сопровождающийся болью за грудиной, чувство сухости в носу и глотке, повышение температуры до 38,7°C, озноб, боль в мышцах, головную боль и общую слабость.

Анамнез заболевания: со слов пациента заболел 3 дня назад, когда впервые отметил резкий подъем температуры тела до 38 °C, сопровождающийся ознобом, головокружением, болями в мышцах, головной болью и общей слабостью, появился непродуктивный кашель. На следующее утро симптомы усилились, появились чувство сухости в носу и глотке, малопродуктивный кашель, сопровождающийся болью за грудиной. Принимал «парацетамол» с последующим облегчением состояния на несколько часов. В связи с отсутствием положительной динамики обратился в поликлинику к врачу-терапевту с целью получения лечения.

Анамнез жизни: Рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: ветряная оспа в детстве. Вредные привычки: отрицает. Травмы, операции, гемотрансфузии: отрицает. Прием лекарственных препаратов: отрицает. Наследственность: неотягощена.

Аллергологический анамнез: неотягощен

Эпидемиологический анамнез: Выезд за пределы РФ последние 2 недели: отрицает. Контакт с инфекционными больными, больными ОРВИ и гриппом, лихорадящими больными за последние 2 недели: 4 дня назад у нескольких коллег на работе отмечались схожие симптомы. Вакцинация от гриппа: нет.

Физикальный осмотр: Температура: 38,6 °C. Рост: 170 см, масса тела: 72 кг, ИМТ: 24,9 кг/м². Общее состояние: средней степени тяжести. Сознание: ясное. Положение: активное. Телосложение: нормостеническое. Кожные покровы (цвет, влажность, тургор): физиологической окраски. Тургор в норме. Сыпь: нет. Видимые слизистые: гиперемированы, влажные, инъекция сосудов склер. Отеки: нет. Зев и небные дужки: гиперемированы. Миндалины: гиперемированы, без налета. Периферические лимфатические узлы: не увеличены.

Костно-мышечная система: Боли в мышцах.

Система органов дыхания: свободное. ЧДД 22/мин. SpO₂ — 97%. Грудная клетка правильной формы, при пальпации безболезненна, голосовое дрожание не изменено, в акте дыхания вспомогательные мышцы не участвуют, дистанционные хрипы не слышны. Одышка: нет. Перкуторно: звук ясный лёгочный. Аускультативно: дыхание жесткое, проводится во все отделы. Хрипы: единичные сухие рассеянные хрипы, преимущественно на фазе выдоха

Сердечно-сосудистая система: АД 110/70 мм рт/ст. ЧСС: 90уд/мин. Пульс ритмичный, симметричный, удовлетворительного напряжения и наполнения. Сердечные тоны приглушены, ритм правильный. Патологические шумы не выслушиваются

Система органов пищеварения: Язык чистый, влажный. Живот не увеличен, симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания, при пальпации безболезненный, симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Печень не увеличена, край печени эластичный, ровный, безболезненный. Селезёнка не увеличена. Стул: регулярный, оформленный, без патологических примесей

Мочевыделительная система: Симптом поколачивания отрицательный. Мочеиспускание свободное, безболезненное

Нервная система и органы чувств: Менингеальные симптомы отрицательные. Очаговой неврологической симптоматики нет

Предварительный диагноз: Острый бронхит вирусной этиологии, необструктивный, средней степени тяжести, неосложненное течение, период разгара, неосложненный

Режим: амбулаторный

План обследования:

1. **Лабораторные:** Общий (клинический) анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ); Исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови); Экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А и на вирус гриппа;
2. **Инструментальные:** Пульсоксиметрия; Рентгенография ОГК

План лечения:

1. **Немедикаментозные методы лечения:** Диета: сбалансированное, легкоусвояемое питание; Обильное теплое питье до 2-х литров в сутки (щелочная минеральная вода, отвар шиповника, чай, морсы и др.)
2. **Медикаментозные методы лечения:** *парацетамол перорально 325- 500 мг 2-3 раза в сутки при температуре выше 38 С; Ацетилцистеин 0,6 г внутрь 1 раз в сутки*

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с «14.07.2026» по «22.07.2026»

Явка: 22.07.2026

1.5 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями риновирусной инфекции, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина, 35 лет

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы: на затруднение носового дыхания через оба носовых хода, обильные выделения из носа водянистого характера, чихание.

Анамнез заболевания: со слов пациента симптомы появились 2 дня назад, когда ощутил сухость, жжение и царапанье в носовых ходах, чихание. Вчера пациент стал отмечать затруднение носового дыхания через оба носовых хода, обильную ринорею водянистого характера и усиление чихания. В связи с отсутствием положительной динамики обратился в поликлинику к врачу-терапевту с целью получения лечения.

Анамнез жизни: Рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: ветряная оспа в детстве. Вредные привычки: отрицает. Травмы, операции, гемотрансфузии: отрицает. Прием лекарственных препаратов: отрицает. Наследственность: неотягощена.

Аллергологический анамнез: неотягощен

Эпидемиологический анамнез: Выезд за пределы РФ последние 2 недели: отрицает. Контакт с инфекционными больными, больными ОРВИ и гриппом, лихорадящими больными за последние 2 недели: отрицает.

Физикальный осмотр: Температура: 37,2°C. Рост: 170 см, масса тела: 72 кг, ИМТ: 24,9 кг/м². Общее состояние: удовлетворительное. Сознание: ясное. Положение: активное. Телосложение: нормостеническое. Кожные покровы: физиологической

окраски, в области крыльев и преддверия носа определяется мацерация кожи. Тургор в норме. Сыпь: нет. Видимые слизистые: гиперемированы, влажные. Отеки: нет. Зев и небные дужки: розовые, влажные, стекание слизистого отделяемого по задней стенке глотки. Миндалины: без налета. Периферические лимфатические узлы: не увеличены.

Костно-мышечная система: Походка и поза в норме. Боли в мышцах, суставах, костях: нет. Деформации костей, суставов: нет. Объем движений в суставах: в норме.

Система органов дыхания: дыхание носом затруднено. ЧДД 17/мин. SpO₂ — 97%. Грудная клетка правильной формы, при пальпации безболезненна, голосовое дрожание не изменено, в акте дыхания вспомогательные мышцы не участвуют, дистанционные хрипы не слышны. Одышка: нет. Перкуторно: звук ясный лёгочный. Аускультативно: дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Хрипы: нет

Сердечно-сосудистая система: АД 120/80 мм рт/ст. ЧСС: 80 уд/мин. Пульс ритмичный, симметричный, удовлетворительного напряжения и наполнения. Сердечные тоны ясные ритмичные. Патологические шумы не выслушиваются

Система органов пищеварения: Язык чистый, влажный. Живот не увеличен, симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания, при пальпации безболезненный, симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Печень не увеличена, край печени эластичный, ровный, безболезненный. Селезёнка не увеличена. Стул: регулярный, оформленный, без патологических примесей

Мочевыделительная система: Симптом поколачивания отрицательный. Мочеиспускание свободное, безболезненное

Нервная система и органы чувств: Менингеальные симптомы отрицательные. Очаговой неврологической симптоматики нет

Предварительный диагноз: Острый ринит, типичное течение, легкой степени тяжести, неосложненное течение, предположительно риновирусной этиологии

Режим: амбулаторный

План обследования:

1. **Лабораторные:** Общий (клинический) анализ крови; Общий (клинический) анализ мочи; Экспресс-ИХА на АГ гриппа А, В, ОРВИ в мазках со слизистой
2. **Инструментальные:** Пульсоксиметрия

План лечения:

1. **Немедикаментозные методы лечения:** Диета: сбалансированное, легкоусвояемое питание; Обильное теплое питье до 2-х литров в сутки (щелочная минеральная вода, отвар шиповника, чай, морсы и др.)
2. **Медикаментозные методы лечения:** *парацетамол перорально по 1-2 табл. (500- 1000 мг) до 4 раз в сутки при температуре выше 38 С; Промывание носа физиологическим раствором, орошение солевыми растворами; Нафазолин (при затруднении дыхания)– интраназально (в каждый носовой ход) по 1–3 капли 0,05% раствора 3–4 раза в сутки не более 5 дней*

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с «14.07.2026» по «18.07.2026»

Явка: 18.07.2026

1.6 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями парагриппа, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина 40 лет

Место работы: ООО "ЯНДЕКС. ТАКСИ", водитель

Жалобы: со слов пациента: на повышение температуры тела до 37,8-38,2 0С, сопровождающееся слабостью, ломотой мышц, отсутствием аппетита; осиплость голоса, грубый, «лающий», раздражающий кашель без отделения мокроты, заложенность носа со скудными выделениями.

Анамнез заболевания: заболел пять дней назад, ухудшение самочувствия связывает с контактом больным ОРВИ (подвозил клиента с похожей симптоматикой). Через три дня появилось першение в горле, сухой кашель, заложенность носа, на следующий день присоединились осиплость голоса и повышение температуры до 38,0С. Принимал парацетамол с кратковременным эффектом. Сегодня утром отметил нарастание слабости, появление грубого «лающего» кашля, голос почти отсутствует. В связи с нарастанием симптоматики обратился в поликлинику к врачу терапевту-участковому по месту жительства.

Анамнез жизни: травмы, операции, заболевания не установлены, наследственность не отягощена, вредные привычки отрицает.

Эпидемиологический анамнез: контакт с инфекционным больным-да, подвозил клиента с симптомами ОРВИ 7 дней назад. Выезд за пределы РФ за последние 2 месяца отрицает.

Аллергологический анамнез: не отягощен.

Физикальный осмотр:

Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 180 см, масса тела 77 кг (ИМТ 24). Температура тела 38,2С.

Кожные покровы обычной окраски, умеренно влажные. Ногти обычной окраски. Видимые слизистые (ротоглотка): гиперемия задней стенки глотки, зернистость, умеренный отек, миндалины не увеличены, налетов нет. Щитовидная железа не пальпируется. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы: увеличение заднешейных и подчелюстных узлов до 1,0-1,5 см, подвижные, безболезненные. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравертебральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система: Дыхание через нос затруднено с обеих сторон, отделяемое скудное слизистое. Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация болезненна во всех отделах, грудная клетка эластичная. Сравнительная перкуссия ясный легочный звук над всеми полями. При аускультации дыхание жесткое, выслушиваются свистящие хрипы на выдохе, преимущественно в верхних отделах легких. ЧДД 22 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

Сердечно-сосудистая система: Область сердца не изменена. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии левая граница сердца на 1,5 см медиальнее среднеключичной линии. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 96 ударов в минуту, АД 120/75 мм.рт.ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система: Язык влажный, обложен белым налетом у корня. Аппетит снижен. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Симптом раздражения брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день самостоятельный.

Мочевыделительная система: Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Диагноз: ОРВИ, острый ларинготрахеит средней степени тяжести, предположительно вызванный вирусом парагриппа.

Режим: амбулаторный

Обследования:

- **Лабораторные:**
 - клинический анализ крови для оценки воспалительного ответа, исключения бактериальной инфекции (лейкоцитоз, сдвиг формулы, СОЭ)
 - общий анализ мочи
 - биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, креатинин, СРБ)
- **Инструментальные:**
 - пульсоксиметрия
 - молекулярно-генетическое исследование (ПЦР) мазка из носо- и ротоглотки на определение возбудителя ОРВИ

Лечение:

Немедикаментозные методы лечения: постельный режим на период лихорадки, обильное теплое питье (до 2-2,5 л/сут): чай с малиной, мёдом, отвар шиповника, морсы. Диета- ОВД.

Медикаментозные методы лечения: осельтамивир 75 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней, парацетамол перорально по 1-2 табл. (500- 1000 мг) до 4 раз в сутки при температуре выше 38 С; Бутамират – внутрь по 15 мл 4 раза в сутки (сироп)

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с 28.06.2026 до 06.07.2026.

Явка: 06.07.2026 с результатами анализов и ПЦР.

1.7 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями острого фолликулярного тонзиллита, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина 40 лет

Место работы: ООО "ЯНДЕКС. ТАКСИ", водитель

Жалобы: со слов пациента: на повышение температуры тела до 39 0С, сопровождающееся слабостью, ознобом, ломотой мышц, суставов, головной болью, отсутствием аппетита; сильная боль в горле при глотании с иррадиацией боли в правое ухо.

Анамнез заболевания: заболел остро два дня назад, связывает с переохлаждением накануне (работал в автомобиле с открытым окном, пил холодную воду). Отмечает резкое повышение температуры тела до 39,2 0С, озноб, выраженную боль в горле при глотании, иррадиацию боли в правое ухо, сильную головную боль, ломоту во всем теле. Принимал парацетамол без значительного эффекта. В связи с нарастанием симптоматики обратился в поликлинику к терапевту-участковому.

Анамнез жизни: травмы, операции, заболевания не установлены, наследственность не отягощена, вредные привычки отрицает.

Эпидемиологический анамнез: контакт с инфекционным больным отрицает. Выезд за пределы РФ за последние 2 месяца отрицает.

Аллергологический анамнез: не отягощен.

Физикальный осмотр:

Общее состояние **средней тяжести**. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 180 см, масса тела 77 кг (ИМТ 24). Температура тела 38,9С.

Кожные покровы бледные, горячие, влажные. **Фарингоскопия:** двусторонняя выраженная гиперемия и инфильтрация мягкого неба и дужек, яркая гиперемия и увеличение миндалин до 2 степени с бугристой поверхностью. В некоторых местах наличие желтовато-белых точек величиной 1-3 мм, заполненные зеленовато-желтым отделяемым. Гиперемия задней стенки глотки, язычок отечен. Щитовидная железа не пальпируется. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы: увеличение переднешейных и подчелюстных узлов до 1,5-2,0 см, подвижные, болезненные, не спаянные с окружающей тканью. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравертебральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система: Дыхание через нос свободное с обеих сторон, отделяемое отсутствует. Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация болезненна во всех отделах, грудная клетка эластичная. Сравнительная перкуссия ясный легочный звук над всеми полями. При аускультации дыхание везикулярное над всей

поверхностью легких, хрипов нет. ЧДД 22 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

Сердечно-сосудистая система: Область сердца не изменена. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии левая граница сердца на 1,5 см медиальнее среднеключичной линии. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 96 ударов в минуту, АД 115/75 мм.рт.ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система: Язык сухой, обложен белым налетом. Аппетит снижен. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Симптом раздражения брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день самостоятельный.

Мочевыделительная система: Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Диагноз: Острый фолликулярный тонзиллит средней степени тяжести.

Режим: амбулаторный

Обследования:

· **Лабораторные:**

- клинический анализ крови для оценки воспалительного ответа, (оценить лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг формулы, СОЭ)
- клинический анализ мочи
- биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, СРБ) для исключения тонзиллогенных осложнений
- мазок из зева и носа на дифтерию (бацилла Леффлера)
- экспресс-тест на БГСА
- микробиологическое исследование мазка из ротоглотки с определением чувствительности к антибиотикам.

· **Инструментальные:**

- Электрокардиография для оценки сердечной деятельности

Лечение:

1.Немедикаментозные методы лечения: постельный режим на период лихорадки, затем домашний режим с исключением физических нагрузок, обильное теплое питье (до 2-2,5 л/сут): чай с лимоном, морсы, минеральная негазированная вода. Диета-

ОВД. Использование индивидуальной посуды, полотенца, ограничение контактов с членами семьи.

2. Медикаментозные методы лечения:

- 1) антибактериальная терапия назначается после получения положительного стрептатеста или при высоком клиническом подозрении на БГСА: амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 10 дней.
- 2) симптоматическая терапия: парацетамол 500 мг внутрь при температуре $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ и/или выраженной боли, но не более 4 раз в сутки, не более 3–5 дней
- 3) Местная терапия:
 - Полоскание ротоглотки 2% раствором соды (1 ч.л. на стакан теплой воды) или настоем ромашки/календулы – 4–5 раз в день после еды.
 - Местные антисептики в виде спрея: бензидамин (Тантум Верде) 0,1 5% раствор – орошение полости рта 4–5 раз в день, или гексэтидин (Стопангин) – также 3–4 раза в день.
 - Для обезболивания – леденцы с бензокаином и тиротрицином (граммицидин) – рассасывать до 5 раз в день, строго по инструкции.

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с 28.06.2026 до 09.07.2026.

Явка: 02.07.2026 для оценки динамики и при необходимости коррекции терапии, с результатами анализов.

1.8 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями респираторно-синцитиальной инфекции, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина 58 лет

Место работы: ООО "ЯНДЕКС. ТАКСИ", водитель

Жалобы: со слов пациента На слабость, недомогание, повышение температуры тела до $37,8^{\circ}\text{C}$, заложенность носа с необильным серозным отделяемым, приступообразный кашель со слизистой мокротой, сопровождающийся саднением и болью за грудиной, осиплость голоса. Кашель усиливается при разговоре и глубоком вдохе. Отмечает, что кашель изнуряющий, нарушает сон.

Анамнез заболевания: Считает себя больным в течение 4 дней, когда появились вышеуказанные жалобы. Заболевание началось постепенно: сначала появилась заложенность носа и першение в горле, на 2-й день присоединился сухой кашель и субфебрильная температура. Самостоятельно принимал «Парацетамол» 500 мг 2 раза в сутки, «Амброксол» 30 мг 3 раза в сутки,

назальные сосудосуживающие капли (название не помнит). Отмечает незначительный кратковременный эффект от приема жаропонижающих, кашель усиливается, температура сохраняется на субфебрильных цифрах. В связи с нарастанием симптоматики обратился в поликлинику к врачу терапевту-участковому по месту жительства.

Анамнез жизни: травмы, операции, заболевания не установлены, наследственность не отягощена, вредные привычки- курит в течение 20 лет (пачка в день).

Эпидемиологический анамнез: контакт с инфекционным больным-да, 6 дней назад заболела супруга (жалобы на насморк, кашель, температуру 38,0°C). Выезд за пределы РФ за последние 2 месяца отрицает.

Аллергологический анамнез: не отягощен.

Физикальный осмотр:

Общее состояние **средней тяжести**. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 180 см, масса тела 77 кг (ИМТ 24). Температура тела 37,8С.

Кожные покровы обычной окраски, умеренно влажные, чистые. Ногти обычной окраски. Видимые слизистые (ротоглотка): гиперемия задней стенки глотки, зернистость, умеренный отек, миндалины не увеличены, налетов нет. Щитовидная железа не пальпируется. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы: увеличение подчелюстных узлов до 1,0см, подвижные, безболезненные. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравертебральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система: Дыхание через нос затруднено с обеих сторон, отделяемое скудное слизистое. Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация болезненна во всех отделах, грудная клетка эластичная. Сравнительная перкуссия ясный легочный звук над всеми полями. При аускультации дыхание везикулярное, ослабленное в нижних отделах, выслушиваются сухие рассеянные хрипы, единичные влажные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах легких с обеих сторон. ЧДД 20 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

Сердечно-сосудистая система: Область сердца не изменена. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии левая граница сердца на 1,5 см медиальнее среднеключичной линии. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 96 ударов в минуту, АД 120/75 мм.рт.ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система: Язык влажный, обложен белым налетом у корня. Appetit снижен. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Симптом раздражения

брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день самостоятельный.

Мочевыделительная система: Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Диагноз: ОРВИ, острый катаральный бронхит средней степени тяжести, предположительно вызванный респираторно-синцитиальным вирусом, неосложненное течение.

Режим: амбулаторный

Обследования:

· **Лабораторные:**

- клинический анализ крови для оценки воспалительного ответа, исключения бактериальной инфекции (лейкоцитоз, сдвиг формулы, СОЭ)
- общий анализ мочи
- биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, креатинин, СРБ)
- молекулярно-генетическое исследование (ПЦР) мазка из носо- и ротоглотки на определения возбудителя ОРВИ

· **Инструментальные:**

- пульсоксиметрия
- рентгенография органов грудной клетки

Лечение:

1. **Немедикаментозные методы лечения:** постельный режим на период лихорадки, обильное теплое питье (до 2-2,5 л/сут): чай с малиной, мёдом, отвар шиповника, морсы. Диета- ОВД. Соблюдать физический и голосовой покой, проводить аэрацию помещения.
2. **Медикаментозные методы лечения:** умифеновир 200 мг 4 раза в сутки 5 дней, парацетамол перорально по 1-2 табл. (500- 1000 мг) до 4 раз в сутки при температуре выше 38 С, амброксол 30 мг по 1 таблетке 3 раза в сутки, курс 5-7 дней, ксилометазолин 0,1% спрей- интраназально по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза в день, не более 5 дней.

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с 28.06.2026 до 02.07.2026.

Явка: 02.07.2026 с результатами анализов, для решения вопроса о продлении ЛН, коррекции терапии, контрольной аускультации и решения вопроса о проведении рентгенографии ОГК при сохранении кашля.

1.9 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями хронического тонзиллита в стадии обострения, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина 40 лет

Место работы: ООО "ЯНДЕКС. ТАКСИ", водитель

Жалобы: со слов пациента: Беспокоит постоянная боль в горле, усиливающаяся при глотании, ощущение "комка" и царапания. По утрам отхаркиваются гнойные пробки с неприятным запахом. Температура поднималась до 37,8 °С, слабость, ломота в суставах

Анамнез заболевания: Считает себя больным в течение 4- 5 дней, когда после переохлаждения (работа на улице) появились першение в горле, сухость. Самостоятельно принимал леденцы с антисептиками (не указал названия) – без эффекта. Накануне обращения отметил ухудшение: усилилась боль при глотании, поднялась температура, появились гнойные выделения из лакун. Ранее (последние 2 года) отмечает эпизоды обострений 2– 3 раза в год, но за медицинской помощью не обращался, лечился полосканиями. В связи с нарастанием симптоматики обратился в поликлинику к терапевту-участковому.

Анамнез жизни: травмы, операции, заболевания не установлены, наследственность не отягощена, вредные привычки отрицает.

Эпидемиологический анамнез: контакт с инфекционным больным отрицает. Выезд за пределы РФ за последние 2 месяца отрицает.

Аллергологический анамнез: не отягощен.

Физикальный осмотр:

Общее состояние **средней тяжести**. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 180 см, масса тела 77 кг (ИМТ 24). Температура тела 38,2С.

Кожные покровы бледные, горячие, влажные. Фарингоскопия: Миндалины увеличены до 2-й степени, гиперемизированы, отечны. В лакунах – гнойные пробки (бело-жёлтые, легко снимаются, не оставляют кровоточащей поверхности). Видны рубцовые изменения и спайки с дужками (признак хронического тонзиллита), а также признаки Гизе и Зака (застойная гиперемия и отечность краёв дужек). Задняя стенка глотки – гиперемия, гипертрофия боковых валиков. Щитовидная железа не пальпируется. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы: увеличение переднешейных и подчелюстных узлов до 1,5-2,0 см, подвижные, болезненные, не спаянные с окружающей тканью. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравerteбральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система: Дыхание через нос свободное с обеих сторон, отделяемое отсутствует. Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация болезненна во всех отделах, грудная клетка эластичная. Сравнительная перкуссия ясный легочный звук над всеми полями. При аускультации дыхание везикулярное над всей поверхностью легких, хрипов нет. ЧДД 22 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

Сердечно-сосудистая система: Область сердца не изменена. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии левая граница сердца на 1,5 см медиальнее среднеключичной линии. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 96 ударов в минуту, АД 115/75 мм.рт.ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система: Язык влажный, обложен белым налетом. Аппетит снижен. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Симптом раздражения брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день самостоятельный.

Мочевыделительная система: Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Диагноз: Хронический тонзиллит в стадии обострения средней степени тяжести. Острый лакунарный тонзиллит средней степени тяжести.

Режим: амбулаторный

Обследования:

- **Лабораторные:**
 - клинический анализ крови для оценки воспалительного ответа, (оценить лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг формулы, СОЭ)
 - клинический анализ мочи
 - биохимический анализ крови (АСЛ-О, АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, СРБ) для исключения тонзиллогенных осложнений
 - мазок из зева и носа на дифтерию (бацилла Леффлера)
 - экспресс-тест на БГСА
 - микробиологическое исследование мазка из ротоглотки с определением чувствительности к антибиотикам.
- **Инструментальные:**
 - Электрокардиография для оценки сердечной деятельности

Лечение:

1.Немедикаментозные методы лечения: постельный режим на период лихорадки, затем домашний режим с исключением физических нагрузок, обильное теплое питье (до 2-2,5 л/сут): чай с лимоном, морсы, минеральная негазированная вода. Диета-ОВД. Использование индивидуальной посуды, полотенца, ограничение контактов с членами семьи.

2.Медикаментозные методы лечения:

- 1)антибактериальная терапия назначается после получения положительного стрептатеста или при высоком клиническом подозрении на БГСА: амоксициллин 1,5 г/сутки в 3 приема или 2,0 г/сутки в 2 приема 10 дней.
- 2)симптоматическая терапия: парацетамол 500 мг внутрь при температуре $\geq 38,5$ °С и/или выраженной боли, но не более 4 раз в сутки, не более 3– 5 дней
- 3)Местная терапия:
 - Полоскание ротоглотки 2% раствором соды (1 ч.л. на стакан теплой воды) или настоем ромашки/календулы – 4– 5 раз в день после еды.
 - Местные антисептики в виде спрея: бензидамин (Тантум Верде) 0,1 5% раствор – орошение полости рта 4– 5 раз в день, или гексэтидин (Стопангин) – также 3– 4 раза в день.
 - Для обезболивания – леденцы с бензокаином и тиротрицином (граммицидин) – рассасывать до 5 раз в день, строго по инструкции.

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с 28.06.2026 до 09.07.2026.

Явка: 02.07.2026 для оценки динамики и при необходимости коррекции терапии, с результатами анализов.

1.10 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями хронического атрофического гастрита, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: мужчина 50 лет

Место работы: ООО "ЯНДЕКС. ТАКСИ", водитель

Жалобы: со слов пациента: на тупые, ноющие боли в эпигастральной области, возникающие через 30–40 минут после еды, чувство тяжести и переполнения в желудке даже после небольшого количества пищи, отрыжку воздухом, тошноту, периодическую изжогу. В последнее время отмечает снижение аппетита.

Анамнез заболевания: Считает себя больным в течение последних 2–3 лет, когда впервые появились вышеуказанные жалобы. Ранее к врачу не обращался, принимал самостоятельно, с переменным эффектом: альмагель по 1–2 дозы при болях, омепразол 20 мг 1 раз в день курсами по 7–10 дней без значимого улучшения. За медицинской помощью обратился впервые. За последние 2 недели отмечает усиление симптомов, связывает с погрешностями в диете (острая, жирная пища). В связи с нарастанием симптоматики обратился в поликлинику к врачу терапевту-участковому по месту жительства.

Анамнез жизни: травмы, операции, заболевания не установлены, наследственность – у матери рак желудка (диагностирован в 65 лет), у отца – язвенная болезнь желудка, вредные привычки отрицает.

Эпидемиологический анамнез: контакт с инфекционными больными отрицает. Выезд за пределы РФ за последние 2 месяца отрицает.

Аллергологический анамнез: не отягощен.

Физикальный осмотр:

Общее состояние **удовлетворительное**. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 180 см, масса тела 77 кг (ИМТ 24). Температура тела 38,2С.

Кожные покровы обычной окраски, умеренно влажные, чистые. Ногти обычной окраски. Видимые слизистые (ротоглотка): обычной окраски. Щитовидная железа не пальпируется. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы: не пальпируются. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравerteбральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система: Дыхание через нос не затруднено, отделяемого нет. Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация болезненна во всех отделах, грудная клетка эластичная. Сравнительная перкуссия ясный легочный звук над всеми полями. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 20 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

Сердечно-сосудистая система: Область сердца не изменена. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии левая граница сердца на 1,5 см медиальнее среднеключичной линии. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 85 ударов в минуту, АД 120/75 мм.рт.ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система: Язык влажный, обложен белым налетом у корня. Аппетит снижен. Живот при поверхностной пальпации мягкий, при глубокой пальпации в эпигастральной области отмечается умеренная болезненность. Симптом раздражения брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день самостоятельный, оформленный.

Мочевыделительная система: Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Диагноз: Хронический атрофический гастрит, активная фаза, ассоциированный с *Helicobacter pylori* с пониженной секреторной функцией.

Режим: амбулаторный

Обследования:

- **Лабораторные:**
 - Клинический анализ крови (для исключения В12-дефицитной анемии).
 - Биохимический анализ крови: общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, ферритин, витамин В12.
 - Иммунологический:
 - антитела к париетальным клеткам желудка (исключение аутоиммунной природы).
 - Дыхательный уреазный тест или определение антигена *H. pylori* в кале (для подтверждения инфекции и контроля эрадикации) .
 - общий анализ мочи

Инструментальные:

- Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с множественной биопсией слизистой оболочки тела и антрального отдела желудка (золотой стандарт диагностики) .
- Гистологическое исследование биоптатов (подтверждение

атрофии, степени метаплазии, обсемененности *H. pylori*).

- Внутривентрикулярная рН-метрия (при возможности — для объективной оценки кислотообразующей функции)

Лечение:

Немедикаментозные методы лечения: Вариант диеты с механическим и химическим щажением (ЩД). Диета с умеренным ограничением химических и механических раздражителей слизистой оболочки и рецепторного аппарата желудочно-кишечного тракта.

Исключаются острые закуски, приправы, пряности; ограничивается поваренная соль (6 - 8 г/день).

Блюда готовятся в отварном виде или на пару, протертые и непротертые. Температура пищи - от 15 до 60-65°C. Свободная жидкость - 1,5-2 литра. Ритм питания дробный, 5-6 раз в день.

1. Медикаментозные методы лечения:

1) эрадикационная терапия *H.pylori* (при подтверждении инфекции)

- Амоксициллин 1000 мг (внутрь) 2 раза в сутки — 14 дней.
- Кларитромицин 500 мг (внутрь) 2 раза в сутки — 14 дней.
- Ингибитор протонной помпы (например, Омепразол 20 мг) 2 раза в сутки — 14 дней .

2) Заместительная терапия (при подтвержденной ахлоргидрии после рН-метрии):

Натуральный желудочный сок (по 1 столовой ложке во время еды) или бетаин пепсин (Ацидин-пепсин) по назначению врача .

3). Симптоматическая терапия:

- Антацидные препараты (по требованию при болях).

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен

Выдан лист нетрудоспособности №12345576767 с 28.06.2026 до 05.07.2026.

Явка: 03.07.2026 (с результатами ЭГДС и анализа на *H. pylori* для коррекции терапии).

1.11 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями внебольничной пневмонии, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: 23 года, мужской.

Место работы: продавец-кассир магазина “Пятерочка”.

Жалобы: на повышение температуры тела до 38,5С, озноб, выраженную слабость, головную боль, кашель с трудноотделяемой слизистой мокротой, чувство нехватки воздуха при ходьбе по лестнице.

Анамнез заболевания: заболел остро около 2 суток назад. Начало связывает с переохлаждением накануне (длительная работа в холодильной камере магазина). Заболевание началось с чувства “першения” в горле, сухого кашля и повышения температуры тела до 37,8 градусов. Принимал самостоятельно “Терафлю”, “Парацетамол” - эффект временный. На вторые сутки температура повысилась до 38,5 градусов, кашель усилился, появилась одышка. Дошел до поликлиники рядом с домом.

Анамнез жизни: Рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: ветряная оспа в детстве. ОРВИ 1-2 раза в год. Хронические заболевания отрицает. Туберкулез, гепатиты, венерические заболевания отрицает. Травм, операций, гемотрансфузий не было.

Вредные привычки: курит с 17 лет, около 10 сигарет в день (индекс пачка/лет = 3). Алкоголь употребляет эпизодически, преимущественно по праздникам. Употребление психоактивных веществ отрицает.

Эпидемиологический анамнез: контакт с лихорадящими больными в семье и на работе отрицает. За последние 2 недели за пределы города не выезжал. Контакта с птицами, системами кондиционирования и увлажнения не было.

Аллергологический анамнез: не отягощен.

Наследственность: не отягощена.

Физикальный осмотр:

Общее состояние: Средней степени тяжести. Сознание ясное, в месте и времени, собственной личности ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 180 см, масса тела 77 кг (ИМТ 24). Температура тела 38,4С. Кожные покровы: горячие, сухие, гиперемированные. Сыпи, послеоперационных рубцов, пигментных невусов, ушибов нет. Видимые слизистые: гиперемия зева и небных дужек.

Лимфатические узлы: подчелюстные, подмышечные - мягкие, эластичные, безболезненные, подвижные, не спаянные с окружающими тканями, размером 0,5 см. Другие группы не пальпируются.

Опорно-двигательная система: Без видимой деформации. Периферических отеков нет.

Дыхательная система: Грудная клетка правильной формы, обе половины участвуют в акте дыхания. Пальпация: голосовое дрожание асимметрично усилено в проекции нижних отделов правого легкого. Перкуссия: притупление перкуторного звука в нижних отделах правого легкого. Аускультация: в нижней доле правого легкого - ослабленное везикулярное дыхание, выслушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы и крепитация. Слева - везикулярное дыхание, побочных дыхательных шумов нет. ЧДД 27 в мин. SpO₂ 97%.

Сердечно-сосудистая система: ЧСС 96 в мин. АД 111/71 мм рт. ст. (тенденция к гипотонии). Тоны ясные, ритмичные, шумов нет.

Пищеварительная система: язык влажный, обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется.

Мочевыделительная система: симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: сознание ясное, адекватен, критичен. Менингеальных знаков нет. Чувствительность не нарушена.

Диагноз: Внебольничная пневмония, предположительно смешанной этиологии (St. pneumoniae и M. pneumoniae), очаговая, с локализацией в нижней доле правого легкого, средней степени тяжести, ДН - 0, в стадии разгара.

Режим: амбулаторный, на период лихорадки - постельный.

Обследования:

· Лабораторные:

- Общий (клинический) анализ крови;
- Общий (клинический) анализ мочи;
- С-реактивный белок;
- СОЭ.

· Инструментальные:

- пульсоксиметрия;
- рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковых проекциях для подтверждения диагноза;
- Повторное (контрольное) рентгенологическое исследование при положительной клинической динамике не ранее чем через 14 дней после начала антибактериального лечения.

Лечение:

Немедикаментозные методы лечения:

- Соблюдать постельный режим на весь лихорадочный период;
- Проветривание комнаты, увлажнение воздуха;
- Диета: Обильное питье (до 2-2,5 л/сут - морсы, вода, щелочное питье (минеральная вода), отвар шиповника). Легкая, механически щадящая пища, богатая белком и витаминами;
- Отказ от вредных привычек.

Медикаментозные методы лечения:

- Амоксициллин+клавуланат внутрь 875+125 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней;
- Азитромицин 500 мг 1 раз в сутки - макролид для подавления атипичных внутриклеточных возбудителей, которые не чувствительны к бета-лактамам;

- Парацетамол 500 мг или Ибупрофен 400 мг внутрь (не более 3-4 раз/сут) - симптоматически при повышении температуры тела более 38,5 градусов ;
- Ацетилцистеин 600 мг 1 раз/сут растворить в стакане воды или Амброксол 30 мг 3 раза/сут - муколитики при вязкой и плохо отделяющейся мокроте.

Экспертиза трудоспособности:

Выдан лист нетрудоспособности №1234567890 с «14.07.2026» по «20.07.2026»

Повторная явка 20.07.2026 с результатами лабораторных и инструментальных обследований. При отсутствии положительной динамики - вопрос о продлении ЛН на врачебной комиссии и возможной госпитализации.

1.12. Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями хронического неатрофического гастрита в стадии обострения, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: 40 лет, мужской.

Место работы: водитель маршрутки (это не шутки мы встретились в маршрутке).

Жалобы: на чувство тяжести и распирания в эпигастральной области, возникающее через 30-40 минут после еды; периодические тупые, ноющие боли в эпигастрии средней интенсивности, без четкой иррадиации; отрыжку воздухом, иногда с кисловатым привкусом, после приема пищи; снижение аппетита в последние 2-3 недели; незначительную тошноту по утрам, проходящую после завтрака.

Анамнез заболевания: считает себя больным в течение примерно 1,5-2 лет, когда впервые отметил появление дискомфорта в эпигастрии после еды. Ранее за медицинской помощью не обращался, обследований не проходил, лечение не получал, периодически принимал антацидные препараты («Алмагель», «Ренни») без эффекта. В течение последнего месяца отмечает постепенное нарастание симптомов: усилилась тяжесть после еды, появились тошнота по утрам и отрыжка. Связывает ухудшение с нарушением режима питания на фоне интенсивной работы (нерациональное питание, «перекусы на ходу», прием пищи 1-2 раза в день, употребление острой и жирной пищи). Настоящее обострение длится около 2 недель.

Анамнез жизни: Рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: ветряная оспа в детстве. ОРВИ 1-2 раза в год. Хронические заболевания отрицает. Туберкулез, гепатиты, венерические заболевания отрицает. Травм, операций, гемотрансфузий не было.

Вредные привычки: курит около 15 лет по 10-15 сигарет в день (индекс пачка/лет = 11,25). Алкоголь употребляет эпизодически, преимущественно по праздникам. Употребление психоактивных веществ отрицает.

Эпидемиологический анамнез: контакт с лихорадящими больными в семье и на работе отрицает. За последние 2 недели за пределы города не выезжал. Кишечные инфекции в последние 6 месяцев отрицает.

Аллергологический анамнез: не отягощен.

Наследственность: у отца - язвенная болезнь желудка, у матери - хронический гастрит. Онкологические заболевания у родственников отрицает.

Физикальный осмотр:

Общее состояние: удовлетворительное. Сознание ясное, положение активное.

Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 180 см, масса тела 77 кг (ИМТ 24). Кожные покровы: обычной окраски, чистые, влажные. Тургор и эластичность сохранены. Видимые слизистые: розовые, влажные, чистые. Лимфатические узлы: подчелюстные, подмышечные - мягкие, эластичные, безболезненные, подвижные, не спаянные с окружающими тканями, размером 0,5 см. Другие группы не пальпируются. Опорно-двигательная система: Без видимой деформации. Периферических отеков нет.

Дыхательная система: грудная клетка правильной формы. Перкуторный звук ясный легочной. Аускультативно: везикулярное дыхание, хрипов нет.

Сердечно-сосудистая система: область сердца без видимых изменений. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения, 76 уд/мин. АД 130/80 мм рт. ст.

Пищеварительная система: осмотр полости рта: Язык влажный, обложен беловатым налетом у корня. Живот: при осмотре правильной формы, не вздут, участвует в акте дыхания. При поверхностной пальпации мягкий, безболезненный. При глубокой пальпации определяется умеренная болезненность в пилорoduоденальной зоне (эпигастрий, справа от средней линии). Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Печень и селезенка не пальпируются (край печени безболезненный, эластичный). Стул без особенностей (по словам пациента).

Мочевыделительная система: симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: сознание ясное, адекватен, критичен. Менингеальных знаков нет. Чувствительность не нарушена.

Диагноз: Хронический неатрофический (поверхностный) антральный гастрит, фаза обострения.

Режим: амбулаторный

Обследования:

Лабораторные:

- Общий анализ крови (ОАК) — для исключения анемии (В12-дефицитная или железодефицитная анемия могут сопровождать гастрит);
- Общий анализ мочи;
- Общий белок;
- Билирубин;
- АЛТ;
- АСТ;
- Амилаза;
- Глюкоза - для оценки функции поджелудочной железы и печени;
- Исследование кала на антиген *H. pylori* — высокочувствительный неинвазивный метод диагностики.

· Инструментальные:

- УЗИ органов брюшной полости — для исключения сопутствующей патологии гепатобилиарной системы и поджелудочной железы;
- Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией — «золотой стандарт» диагностики, позволяющий визуализировать состояние слизистой оболочки желудка, оценить выраженность воспаления, наличие эрозий, атрофии, кишечной метаплазии и провести гистологическое исследование биоптатов;
- Гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка — для верификации диагноза, оценки степени активности воспаления, выраженности атрофии и метаплазии; определение степени контаминации *H. pylori*;
- Уреазный дыхательный тест — для подтверждения *H. pylori*-инфекции (при невозможности выполнения ЭГДС с биопсией).

Лечение:

Немедикаментозные методы лечения:

- Исключить физические и психоэмоциональные перегрузки;
- Диета: частое дробное питание (5-6 раз в день, небольшими порциями), исключение механических и химических раздражителей слизистой оболочки желудка, исключение острых, жареных, копченых, маринованных блюд, крепких мясных и рыбных бульонов, кофе, газированных напитков, алкоголя. Пища отварная, приготовленная на пару, протертая (в период обострения). Ограничение соли до 6-8 г/сутки;
- Исключение курения (проведение беседы о вреде курения для слизистой оболочки желудка);
- Контроль эрадикации через 4-6 недель - 13С-уреазный дыхательный тест.

Медикаментозные методы лечения:

- Ингибитор протонной помпы (ИПП): Эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) 14 дней;
- Препарат висмута: Висмута трикалия дицитрат (Де-Нол) 240 мг 2 раза в сутки (за 30 минут до еды и на ночь) — 14 дней.
- Антибактериальные препараты: Амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки — 14 дней. Кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки — 14 дней.

Примечание: при выявлении резистентности к кларитромицину может быть заменен на метронидазол 500 мг 3-4 раза в сутки согласно клиническим рекомендациям.

- Антацидные препараты (симптоматическая терапия): При сохранении изжоги и болей — Маалокс или Алмагель по 1 пакетику или 15 мл через 1-1,5 часа после еды и на ночь, не более 5-7 дней.
- Прокинетики (при выраженной диспепсии): Домперидон (Мотилиум) 10 мг 3 раза в день за 15-20 минут до еды — 7-10 дней (для уменьшения тошноты, чувства тяжести).

Экспертиза трудоспособности:

В связи с обострением хронического гастрита, наличием выраженного болевого синдрома пациент временно нетрудоспособен.

Выдан лист нетрудоспособности №1234567890 с «14.07.2026» до «20.07.2026».

Повторная явка 20.07.2026 с результатами лабораторных и инструментальных обследований для оценки эффективности лечения и решения вопроса о продлении листка нетрудоспособности.

1.13. Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Возраст и пол: 44 года, мужской.

Место работы: водитель-дальнобойщик ИП «Ласточка»

Жалобы: На интенсивные «голодные» боли в эпигастральной области, возникающие через 2–2,5 часа после еды, а также ночные боли, которые заставляют просыпаться и принимать пищу (после еды боли стихают). Беспокоит изжога, кислая отрыжка, иногда тошнота натощак. Стул склонен к запорам.

Анамнез заболевания: Считает себя больным около 4 лет. Обострения возникают весной и осенью. В прошлые разы «заедал» боли антацидами (Ренни, Алмагель) — помогало временно. Настоящее ухудшение связывает с длительным рейсом (3 недели): питался всухомятку, пил растворимый кофе и энергетики, много курил, был в стрессовой ситуации из-за поломки фуры. За медицинской помощью ранее не обращался, обследование не проходил.

Анамнез жизни: Рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: ветряная оспа в детстве. ОРВИ 1-2 раза в год. Хронические заболевания отрицает. Туберкулез, гепатиты, венерические заболевания отрицает. Травм, операций, гемотрансфузий не было.

Вредные привычки: курит около 15 лет по 10-15 сигарет в день (индекс пачка/лет = 11,25). Алкоголь употребляет эпизодически, преимущественно по праздникам. Употребление психоактивных веществ отрицает.

Эпидемиологический анамнез: контакт с лихорадящими больными в семье и на работе отрицает. За последние 2 недели за пределы города не выезжал. Кишечные инфекции в последние 6 месяцев отрицает.

Аллергологический анамнез: неотягощен.

Наследственность: неотягощена.

Физикальный осмотр:

Общее состояние: средней степени тяжести. Сознание ясное, положение активное.

Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 180 см, масса тела 77 кг (ИМТ 24). Кожные покровы: обычной окраски, чистые, влажные. Тургор и эластичность сохранены. Видимые слизистые: бледно-розовые, влажные, чистые. Лимфатические узлы: подчелюстные, подмышечные - мягкие, эластичные, безболезненные, подвижные, не спаянные с окружающими тканями, размером 0,5 см. Другие группы не пальпируются. Опорно-двигательная система: Без видимой деформации. Периферических отеков нет.

Дыхательная система: Грудная клетка нормостеническая, симметричная. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД = 16/мин.

Сердечно-сосудистая система: область сердца без видимых изменений. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. ЧСС = 72 уд/мин. АД = 130/80 мм рт. ст.

Пищеварительная система: Язык влажный, обложен беловато-серым налетом у корня.

Живот правильной формы, не вздут, участвует в акте дыхания. Видимой перистальтики нет. Подкожная венозная сеть не выражена.

Пальпация: При поверхностной пальпации живот мягкий, умеренная болезненность в эпигастральной области и в пилородуоденальной зоне (справа от средней линии).

Симптомы раздражения брюшины (Щеткина-Блюмберга) отрицательные. Перкуссия: Свободной жидкости в брюшной полости нет (симптома флюктуации нет).

Аускультация: Перистальтика кишечника выслушивается, активная, нормальная.

Печень: Нижний край не выступает из-под реберной дуги, безболезненный, эластичный. Желчный пузырь: Симптомы Ортнера, Мерфи, Кера — отрицательные.

Селезенка: Не пальпируется.

Мочевыделительная система: Поясничная область не изменена. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: сознание ясное, адекватен, критичен. Менингеальных знаков нет. Чувствительность не нарушена.

Диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, обострение, неосложненная форма.

Режим: амбулаторный

Обследования:

Лабораторные:

- Общий анализ крови (для исключения постгеморрагической анемии),
- Общий анализ мочи,
- Билирубин,
- АЛТ,
- АСТ,
- общий белок,
- глюкоза,
- Анализ кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена) — 3-кратно.
- 13С-уреазный дыхательный тест (неинвазивное подтверждение *H. pylori*).

Инструментальные:

- ЭГДС с биопсией — обязательный «золотой стандарт» для визуализации язвы, уточнения ее размеров, стадии, а также забора биоптата на гистологию и определение чувствительности *H. pylori* к антибиотикам (при необходимости).
- Рентгеноскопия желудка с контрастированием барием (при невозможности проведения ЭГДС).

Лечение:

Немедикаментозные методы лечения:

- Диета: питание дробное, 5–6 раз/сут, малыми порциями, в одно и то же время. Исключить: жареное, острое, копченое, маринады, кофе, крепкий чай, алкоголь, газировку, шоколад.
- Образ жизни: Полный отказ от курения! Нормализация режима сна и бодрствования, избегание стрессов. На время лечения — перевод на работу без ночных смен.
- Контроль эффективности эрадикации не ранее, чем через 4-6 недель после окончания лечения антибактериальными препаратами.

Медикаментозные методы лечения:

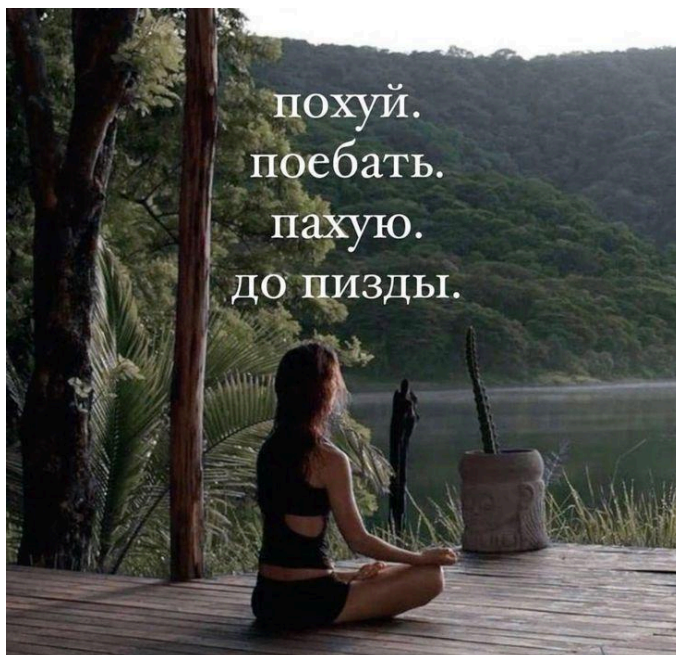
- Ингибитор протонной помпы (ИПП): Эзомепразол 40 мг × 2 раза/сут (за 30 мин до еды) — 14 дней.
- Антибиотики: Кларитромицин 500 мг × 2 раза/сут (после еды) — 14 дней. Амоксициллин 1000 мг × 2 раза/сут (после еды) — 14 дней.

- Препарат висмута: Висмута трикалия дицитрат 240 мг × 2 раза/сут (за 30 мин до еды) — для защиты слизистой и усиления эрадикации.
- Симптоматически: При болях — антациды (Маалокс, Алмагель А) по 1 пакетику через 1,5–2 часа после еды, но не ранее, чем через 2 часа после приема других препаратов, так как есть несовместимость с антибиотиками и ИПП.

Экспертиза трудоспособности:

Выдан лист нетрудоспособности №1234567890 с «14.07.2026» до «28.07.2026».

Повторная явка 28.07.2026 с результатами лабораторных и инструментальных обследований для оценки эффективности лечения с назначением повторной ЭГДС и решения вопроса о продлении листка нетрудоспособности.



1.14 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями гипертонической болезни II стадии, целевой уровень АД не достигнут при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Пациент: 56 лет, мужчина.

Место работы: ООО «Строй-Инвест», прораб.

Жалобы (словами пациента):

На головные боли пульсирующего характера в затылочной области, возникающие преимущественно в утренние часы, ощущение пульсации в висках, периодическое головокружение, мелькание «мушек» перед глазами.

Анамнез заболевания:

Считает себя больным около 5 лет. Впервые повышение АД (до 160/100 мм рт. ст.) зафиксировано на профосмотре. Периодически принимал эналаприл по 10 мг/сут нерегулярно. За медицинской помощью не обращался. В течение последнего месяца отмечает учащение головных болей, повышение АД до 170/100–180/105 мм рт. ст. (измерял дома), снижение переносимости физической нагрузки. Настоящее обращение первичное по поводу АГ.

Анамнез жизни:

Травмы, операции отрицает. Наследственность отягощена: у отца — гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда в 62 года. Курит в течение 30 лет (1 пачка/день). Злоупотребляет алкоголем (до 300 мл крепких напитков в неделю). Питание нерациональное, предпочтение жирной и соленой пище.

Эпидемиологический анамнез: без особенностей. Контакт с инфекционными больными не было. За пределы области не выезжал.

Аллергологический анамнез: непереносимости лекарственных препаратов и пищевых продуктов не отмечает.

Физикальный осмотр:

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, ориентирован в месте, времени и собственной личности, контактен. Телосложение гиперстеническое, рост 172 см, масса тела 96 кг (ИМТ 32,5 — ожирение I степени). Температура тела 36,6 °С. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно, преимущественно по абдоминальному типу (окружность талии 104 см). Отеков нет. Периферические лимфоузлы не пальпируются.

Дыхательная система: Дыхание через нос свободное. Грудная клетка правильной формы, симметрична. При перкуссии ясный легочный звук. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 17 в мин.

Сердечно-сосудистая система: Область сердца не изменена. Пульс напряженный, ритмичный, ЧСС 78 уд/мин. Границы сердца: левая — на 1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии (смещение влево). Тоны сердца приглушены, акцент II тона над аортой. АД 165/100 мм рт. ст. на обеих руках. АД на ногах 170/100 мм рт. ст.

Пищеварительная система: Язык влажный, чистый. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется.

Мочевыделительная система: Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Психоневрологический статус: сознание ясное, адекватен, критичен. Менингеальных знаков нет. Чувствительность не нарушена.

Диагноз:

Основной: Гипертоническая болезнь II стадии. Артериальная гипертензия 2 степени. Ожирение I степени. Дислипидемия. Риск ССО 3 (высокий).
Целевое АД: <130/80 мм рт. ст.

Режим: амбулаторный.

Обследование:

1. Лабораторное:

- Клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты).
- Биохимический анализ крови: глюкоза натощак, креатинин с расчетом СКФ (СКД-EPI), мочевиная кислота, калий, натрий.
- Липидный профиль: общий холестерин, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, триглицериды.
- Общий анализ мочи с микроскопией осадка и определением микроальбуминурии (альбумин/креатинин).

2. Инструментальное:

- ЭКГ в 12 отведениях (с расчетом индексов Соколова–Лайона и Корнеловского показателя).
- Эхокардиография (для оценки гипертрофии миокарда ЛЖ и его диастолической функции).
- УЗИ почек и дуплексное сканирование почечных артерий (для исключения вторичного характера АГ).
- Суточное мониторирование АД (СМАД) — для подтверждения диагноза и оценки суточного профиля.
- Осмотр глазного дна врачом-офтальмологом.

Лечение:

· Немедикаментозное:

- Диета с ограничением поваренной соли до 5 г/сут, животных жиров, легкоусвояемых углеводов.
- Снижение массы тела до целевого ИМТ ($<25 \text{ кг/м}^2$).
- Полный отказ от курения и алкоголя.
- Регулярные аэробные физические нагрузки (ходьба в умеренном темпе 30–40 мин в день, 5–7 дней в неделю).

· Медикаментозное (МНН):

- Периндоприл (ИАПФ) 5 мг 1 раз в сутки (утром) — стартовая доза.
- Индапамид (тиазидоподобный диуретик) 1,25 мг 1 раз в сутки (утром) в составе фиксированной комбинации (периндоприл + индапамид).
- Амлодипин (дигидропиридиновый АК) 5 мг 1 раз в сутки (утром) — добавить при недостаточной эффективности через 2 недели.
- Аторвастатин 20 мг 1 раз в сутки (вечером) — для коррекции дислипидемии.
- Контроль эффективности и коррекция доз через 2 недели.

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен (в связи с гипертоническим кризом в анамнезе и необходимостью подбора терапии).

Выдан лист нетрудоспособности № 123456789012 с «29» июня 2026 г. по «9» июля 2026 г. (10 дней).

Явка: 10.07.2026 с результатами анализов и СМАД для решения вопроса о дальнейшей терапии и продлении/закрытии листка нетрудоспособности.

1.15 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями гипертонической болезни I стадии, артериальной

гипертензии 1 степени, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Пациент: 42 года, женщина.

Место работы: АО «Комфорт-Мебель», менеджер.

Жалобы (словами пациента):

На периодические головные боли ноющего характера в теменной области, возникающие после эмоционального стресса или к концу рабочего дня. На чувство «пульсации» в голове. Иногда отмечает бессонницу.

Анамнез заболевания:

Считает себя больной около 2 лет. Повышение АД (до 145/90 мм рт. ст.) выявлялось при прохождении диспансеризации. К врачу не обращалась, лечение не получала. В течение последних двух месяцев, на фоне повышенной нагрузки на работе, стала чаще отмечать головные боли. Самостоятельно измеряла АД в домашних условиях — 140–145/88–92 мм рт. ст. Настоящее обращение — первичное.

Анамнез жизни:

Травмы, операции отрицает. Наследственность: мать страдает гипертонической болезнью. Не курит. Алкоголь употребляет редко (по праздникам, в небольших количествах). Питание нерегулярное, предпочитает мучное и сладкое. Физическая активность низкая. Менструации регулярные, менопауза 1 год.

Эпидемиологический анамнез: без особенностей.

Аллергологический анамнез: аллергических реакций не выявлено.

Физикальный осмотр:

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, ориентирована, контактна. Телосложение нормостеническое, рост 165 см, масса тела 74 кг (ИМТ 27,2 — избыточная масса тела). Температура тела 36,7 °С.

Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не пальпируются.

Дыхательная система: Дыхание через нос свободное. Грудная клетка симметрична. При перкуссии ясный легочный звук. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16 в мин.

Сердечно-сосудистая система: Область сердца не изменена. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. Границы сердца не смещены. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 74 уд/мин. АД 145/90 мм рт. ст. на правой руке, 140/88 мм рт. ст. на левой руке.

Пищеварительная система: Язык влажный, чистый. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги.

Мочевыделительная система: Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное.

Психоневрологический статус: сознание ясное. Несколько тревожна.

Менингеальных знаков нет.

Диагноз:

Основной: Гипертоническая болезнь I стадии. Артериальная гипертензия 1 степени. Избыточная масса тела. Риск ССО 2 (средний).
Целевое АД: <130/80 мм рт. ст.

Режим: амбулаторный.

Обследование:1. Лабораторное:

- Клинический анализ крови.
- Биохимический анализ крови: глюкоза натощак, креатинин с расчетом СКФ, калий, натрий, мочевиная кислота.
- Липидный профиль (общий ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ).
- Общий анализ мочи (с микроскопией осадка).
- Тест на микроальбуминурию (отношение альбумин/креатинин).

2. Инструментальное:

- ЭКГ в 12 отведениях.
- Эхокардиография (для исключения начальной гипертрофии ЛЖ).
- Суточное мониторирование АД (СМАД) — для исключения гипертонии «белого халата» и оценки средних значений АД.
- Осмотр глазного дна.

Лечение:· Немедикаментозное (приоритетное, так как риск 2):

- Диета с ограничением поваренной соли до 5 г/сут, снижение потребления легкоусвояемых углеводов и животных жиров.
- Нормализация массы тела (целевой ИМТ <25 кг/м²).
- Увеличение физической активности (быстрая ходьба по 30–40 мин 5 раз в неделю).
- Нормализация режима труда и отдыха, управление стрессом (аутотренинг).
- Ограничение алкоголя до 7 единиц в неделю для женщин.
- Контроль АД в домашних условиях с ведением дневника.

· Медикаментозное: лечение не начинать, провести 3-месячный период немедикаментозной коррекции. При отсутствии эффекта (сохранение АД ≥140/90 мм рт. ст.) — начать антигипертензивную терапию.

Экспертиза трудоспособности:

Трудоспособна. Временная нетрудоспособность не показана (отсутствуют кризовые состояния, обострения, угрожающие жизни состояния).

Явка: 30.07.2026 с результатами обследований и дневником АД для решения вопроса о дальнейшей тактике.

1.16 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями стенокардии напряжения II-го функционального

класса, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

Пациент: 64 года, мужчина.

Место работы: ГБОУ «Школа № 54», учитель.

Жалобы (словами пациента):

На давящие, сжимающие боли за грудиной, возникающие при ходьбе по ровному месту на расстояние 400–500 метров (при быстром темпе — раньше), подъеме на 2-й этаж, в холодную или ветреную погоду. Боли иррадиируют в левую руку, шею, длятся 3–5 минут, купируются в покое или через 2–3 минуты после приема нитроглицерина сублингвально. На периодическую одышку при нагрузке.

Анамнез заболевания:

Считает себя больным в течение 3 месяцев, когда впервые появились описанные боли при подъеме по лестнице. В последний месяц отмечает прогрессирование: порог нагрузки снизился (стал возникать при ходьбе на 500 м), боли стали более интенсивными. Принимал нитроглицерин эпизодически, за медицинской помощью ранее не обращался. Настоящее обращение — первичное по поводу стенокардии.

Анамнез жизни:

Травмы, операции отрицает. Наследственность отягощена: отец страдает ИБС, перенес инфаркт миокарда в 60 лет. Курит с 20 лет (в настоящее время — 1 пачка в день). Алкоголь употребляет умеренно. Питание с избытком жиров и соли. АГ в течение последних 8 лет, принимает эналаприл нерегулярно (по самочувствию), АД последнее время 140/85–150/90 мм рт. ст.

Эпидемиологический анамнез: без особенностей.

Аллергологический анамнез: аллергии нет.

Физикальный осмотр:

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, ориентирован, контактен.

Телосложение нормостеническое, рост 174 см, масса тела 85 кг (ИМТ 28,1 — избыточная масса тела). Температура тела 36,5 °С.

Кожные покровы обычной окраски, чистые. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не пальпируются.

Дыхательная система: Дыхание через нос свободное. Грудная клетка симметрична. При перкуссии ясный легочный звук. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 18 в мин.

Сердечно-сосудистая система: Область сердца не изменена. Пульс ритмичный, ЧСС 72 уд/мин. При перкуссии левая граница сердца на 1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. АД 145/90 мм рт. ст. на обеих руках.

Пищеварительная система: Язык влажный. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена.

Мочевыделительная система: Симптом поколачивания отрицательный.

Мочеиспускание свободное.

Психоневрологический статус: сознание ясное, ориентирован, настроение слегка понижено. Менингеальных знаков нет.

Диагноз:

Основной: ИБС: Стенокардия напряжения, функциональный класс II.

Сопутствующий: Гипертоническая болезнь III стадии. Артериальная гипертензия 1 степени. Избыточная масса тела. Риск ССО 4 (очень высокий).

Целевое АД: <130/80 мм рт. ст.

Режим: амбулаторный (в связи с отсутствием нестабильности).

Обследование:

1. Лабораторное:

- Клинический анализ крови (гемоглобин, тромбоциты).
- Биохимический анализ крови: глюкоза натощак, креатинин с СКФ, калий, мочевиная кислота.
- Развернутый липидный профиль (общий ХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ). Целевой ЛПНП <1,4 ммоль/л (для очень высокого риска).
- Тропонин I (высокочувствительный) — для исключения повреждения миокарда.

2. Инструментальное:

- ЭКГ в 12 отведениях в покое.
- Эхокардиография (оценка ФВЛЖ, локальной сократимости, ГЛЖ).
- Велоэргометрия (ВЭМ) или тредмил-тест (нагрузочный тест) для верификации ишемии миокарда, определения функционального класса и пороговой нагрузки.
- Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) — для выявления безболевого ишемии и нарушений ритма.
- Консультация кардиолога для решения вопроса о мультиспиральной КТ-коронарографии или коронароангиографии.

Лечение:

· Немедикаментозное:

- Полное прекращение курения (рекомендована никотинзаместительная терапия).
- Диета с ограничением соли (до 5 г/сут), животных жиров, легкоусвояемых углеводов.
- Контроль массы тела (снижение веса на 5–10%).
- Регулярные дозированные физические нагрузки в зоне «безопасного пульса» (после нагрузочного теста).
- Обучение пациента правилам поведения при приступе стенокардии.

· Медикаментозное (МНН):

- Купирование приступов: Нитроглицерин 0,5 мг сублингвально (повторять каждые 5 минут, не более 3 раз).
- Антиангинальная терапия (улучшение прогноза и симптомов):
 - Бисопролол (β-блокатор) 2,5 мг 1 раз в сутки утром, с титрацией до снижения ЧСС в покое до 55–60 уд/мин (целевая доза до 10 мг/сут).

- Профилактика осложнений (вторичная):
 - Ацетилсалициловая кислота 100 мг 1 раз в сутки (после еды, вечером) — если нет противопоказаний.
 - Аторвастатин 40 мг 1 раз в сутки (вечером) — для агрессивного снижения ЛПНП <1,8 ммоль/л.
- Контроль АГ:
 - Периндоприл (ИАПФ) 2,5 мг 1 раз в сутки утром
 - Индапамид 1,25 мг 1 раз в сутки утром.

Экспертиза трудоспособности:

Нетрудоспособен (в связи с необходимостью проведения обследования, подбора терапии и решения вопроса о стабильности процесса).

Выдан лист нетрудоспособности № 987654321098 с «29» июня 2026 г. по «13» июля 2026 г. (14 дней).

Явка: 14.07.2026 с результатами обследований (ВЭМ, Холтер, анализы) для коррекции терапии и решения вопроса о дальнейшем наблюдении (продление/закрытие листка нетрудоспособности, направление к кардиологу).

1.17 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями стенокардии напряжения I-го функционального класса, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

ФИО: Иванов Иван Иванович

Возраст и пол: 54 года, мужской

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы:

на давящие, сжимающие боли за грудиной, возникающие при физической нагрузке (быстрая ходьба, подъем по лестнице).

Анамнез заболевания:

Считает себя больным в течение последних 2-х месяцев, когда впервые отметил давящие боли за грудиной. Боли связывает с физической нагрузкой и стрессом на работе. Боли проходят самостоятельно в покое за 2-3 минуты. Также отмечает периодическое повышение АД до 150/90 мм рт. ст., сопровождающееся головной болью в затылочной области. За медицинской помощью не обращался, препараты самостоятельно не принимал.

Анамнез жизни:

перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Операции, травмы отрицает. Наследственность по СС отягощена – отец умер в 75 лет от ОИМ.

Эпидемиологический анамнез:

Контакт с инфекционными больными отрицает. За пределы РФ за последние 2 года не выезжал.

Аллергологический анамнез:

Аллергию на лекарственные препараты, пищевые продукты отрицает.

Физикальный осмотр:

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение:

конституциональный тип гиперстенический, рост 175 см, масса тела 95 кг (ИМТ 31). Температура тела 36,6С.

Кожный покров обычной окраски, чистые. Ногти и видимые слизистые (ротоглотки) обычной окраски. Щитовидная железа не пальпируется.

Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет.

Периферические лимфоузлы не пальпируются. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравертебральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система:

Дыхание через нос свободное.

Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация безболезненна, грудная клетка эластичная. Сравнительная

перкуссия: перкуторный звук ясный легочный над всей поверхностью ГК. При аускультации дыхание везикулярное, патологических шумов, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

ССС:

Область сердца не изменена. Пульс 78 уд/мин удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии границы относительной сердечной тупости не расширены. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. ЧСС 78 ударов в минуту, АД 130/80 мм. рт. ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система:

Язык чистый, влажный, без налета. Живот мягкий,

безболезненный во всех отделах. Симптом раздражения брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются.

Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день.

Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с

обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Нервная система:

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не

нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Предварительный диагноз:

Основной диагноз: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, I ФК.

Сопутствующий диагноз: Артериальная гипертензия 3 стадии, 1 степень, риск ССО высокий. Ожирение 1 степени.

Обследование:

1. Лабораторные исследования:

- клинический анализ крови: эритроциты, гемоглобин, лейкоцитарная формула, тромбоциты\

- биохимический анализ крови: глюкоза, креатинин (с расчетом СКФ)\

- липидограмма: общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды

2. Инструментальные исследования:

- ЭКГ в 12 отведениях

- ЭхоКГ с определением ФВ ЛЖ, оценкой локальной сократимости и диастолической функции

- стресс-ЭхоКГ

Лечение:

1. Режим амбулаторный

- Диета: ограничение потребления поваренной соли до 5 г/сут; увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; снизить потребление быстрых углеводов

- Рекомендовано ведение дневника АД и ЧСС

2. Для купирования приступов стенокардии: нитроглицерин таблетки под язык (или спрей) по 0,5 мг по требованию (во время приступа). При неэффективности – вызов СМП.

- для устранения симптомов + профилактика ишемии: Метопролола сукцинат 25 мг 1 раз в сутки утром.

- для профилактики ССО: АСК 75 мг 1 раз в сутки после еды; Розувастатин 10 мг 1 раз в сутки;

- Антигипертензивная: Периндоприл 2,5 мг 1 раз в сутки (целевое АД <140/90 мм рт. ст.)

Экспертиза нетрудоспособности: Пациент трудоспособен.

Явка: к терапевту через 7-10 дней с результатами анализов и ЭхоКГ для оценки эффективности терапии и коррекции дозировок. Пациент направлен на консультацию к врачу кардиологу.

1.18 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями ГЭРБ в стадии обострения, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

ФИО: Иванов Иван Иванович

Возраст и пол: 58 лет, мужской

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы:

на интенсивное жжение за грудиной, возникающее через 10-20 минут после еды, кислую отрыжку.

Анамнез заболевания:

Считает себя больным в течение последнего года, когда впервые появилась изжога после погрешности в диете. Ранее к врачу не обращался, лечился самостоятельно антацидами (Алмагель) курсами по 5-7 дней с временным улучшением. Обострения 2-3 раза в год, обычно осенью и весной. Настоящее ухудшение отмечает в течение последних 2-х недель, когда изжога стала ежедневной, интенсивной, появилась ночная изжога. Прием антацидов в стандартных дозах эффекта не дает. ЭГДС ранее не проводилась.

Анамнез жизни:

перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Операции, травмы отрицает. Наследственность по пищеварительной системе отягощена – у отца язвенная болезнь желудка. Питание нерегулярное, часто ест на ходу, предпочитает жирную и острую пищу.

Эпидемиологический анамнез:

Контакт с инфекционными больными отрицает. За пределы РФ за последние 2 года не выезжал.

Аллергологический анамнез:

Аллергию на лекарственные препараты, пищевые продукты отрицает.

Физикальный осмотр:

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение:

конституциональный тип гиперстенический, рост 172 см, масса тела 95 кг (ИМТ 32). Температура тела 36,6С.

Кожный покров обычной окраски, чистые. Ногти и видимые слизистые (ротоглотки) обычной окраски. Щитовидная железа не пальпируется.

Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет.

Периферические лимфоузлы не пальпируются. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравертебральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система:

Дыхание через нос свободное.

Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация безболезненна, грудная клетка эластичная. Сравнительная перкуссия: перкуторный звук ясный легочный над всей поверхностью ГК. При аускультации дыхание везикулярное, патологических шумов, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

ССС:

Область сердца не изменена. Пульс 78 уд/мин удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии границы относительной сердечной тупости не расширены. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 78 ударов в минуту, АД 130/80 мм. рт. ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система:

Язык чистый, влажный, обложен белым налетом у корня. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Симптом раздражения брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день. Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Нервная система:

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Предварительный диагноз:

Основной диагноз: Гастроэзофагальный рефлюкс без эзофагита (неэрозивная форма). Сопутствующий диагноз: Ожирение 1 степени.

Обследование:

1. Лабораторные исследования:
 - клинический анализ крови: эритроциты, гемоглобин, лейкоцитарная формула, тромбоциты\
 - биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, общий билирубин + фракции, ГГТ, ЩФ, альбумин, креатинин
 - липидограмма: общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды
 - общий анализ мочи
 - анализ кала на скрытую кровь
2. Инструментальные исследования:
 - ЭГДС
 - суточная рН-импедансометрия пищевода
 - МПВР (манометрия пищевода высокого разрешения)
 - рентгенография ОГК

Лечение:

1. Режим амбулаторный

- Диета: ЩД . Принципы дробного питания. Последний прием пищи – не позднее чем за 3 часа до сна. Сниженная калорийность рациона для уменьшения массы тела.

- сон с приподнятым головным концом кровати для уменьшения ночного рефлюкса

2. Антисекреторная терапия: Рабепразол 20 мг 1 раз в день за 30 минут до завтрака

- Ребамипид 100 мг 3 раза в день после еды

- Итоприда гидрохлорид 50 мг 3 раза в день за 15-20 минут до еды

- Вонопразан 20 мг/сут (4 недели)

Экспертиза нетрудоспособности: Пациент трудоспособен.

Явка: к терапевту через 14 дней с результатами анализов и ЭГДС для оценки эффективности терапии и коррекции дозировок. Пациент направлен на консультацию к врачу гастроэнтерологу.

1.19 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями язвенной болезни желудка в стадии обострения, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

ФИО: Иванов Иван Иванович

Возраст и пол: 42 года, мужской

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы:

на боли в эпигастральной области, возникающие через 30-40 минут после еды, ноющие, средней интенсивности.

Анамнез заболевания:

Считает себя больным в течение последних 2 лет, когда впервые появилась боли в животе. Связывает боли с погрешностью в диете. Ранее к врачу не обращался, лечился самостоятельно антацидами (Алмагель) с временным улучшением.

Обострения 2-3 раза в год, обычно осенью и весной. Настоящее ухудшение отмечает в течение последних 2-х недель, когда боли стали более интенсивными и постоянными, перестали купироваться.

Анамнез жизни:

перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Операции, травмы отрицает. Наследственность по пищеварительной системе отягощена – у отца язвенная болезнь желудка. Питание нерегулярное.

Эпидемиологический анамнез:

Контакт с инфекционными больными отрицает. За пределы РФ за последние 2 года не выезжал.

Аллергологический анамнез:

Аллергию на лекарственные препараты, пищевые продукты отрицает.

Физикальный осмотр:

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение: конституциональный тип нормостенический, рост 178 см, масса тела 74 кг (ИМТ 23,4). Температура тела 36,6С.

Кожный покров обычной окраски, чистые. Ногти и видимые слизистые (ротоглотки) обычной окраски. Щитовидная железа не пальпируется.

Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет.

Периферические лимфоузлы не пальпируются. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравертебральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система:

Дыхание через нос свободное.

Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация безболезненна, грудная клетка эластичная. Сравнительная перкуссия: перкуторный звук ясный легочный над всей поверхностью ГК. При аускультации дыхание везикулярное, патологических шумов, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

ССС:

Область сердца не изменена. Пульс 78 уд/мин удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии границы относительной сердечной тупости не расширены. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 78 ударов в минуту, АД 130/80 мм. рт. ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система:

Язык чистый, влажный, обложен белым налетом у корня. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии. Симптом раздражения брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются.

Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день.

Симптом Менделя положительный в эпигастрии. Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Нервная система:

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Предварительный диагноз:

Основной диагноз: Язвенная болезнь желудка, впервые выявленная, предположительно ассоциированная с *Helicobacter pylori*, в стадии обострения.

Обследование:

1. Лабораторные исследования:

- клинический анализ крови: эритроциты, гемоглобин, лейкоцитарная формула, тромбоциты\
- биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, общий билирубин + фракции, ГГТ, ЩФ, альбумин, креатинин
- липидограмма: общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды
- общий анализ мочи
- анализ кала на скрытую кровь
- анализ на уровень гастрина сыворотки крови (исключение Золлингера-Эллисона)

2. Инструментальные исследования:

- ЭГДС + быстрый уреазный тест
- обзорная рентгенография брюшной полости
- КТ органов брюшной полости

Лечение:

1. Режим амбулаторный

- Диета: ЩД на период обострения. Принципы дробного питания.

2. Антисекреторная терапия: Рабепразол 20 мг 1 раз в сутки

- Ребамипид 100 мг 3 раза в день после еды

После получения результатов исследований и подтверждения НР-ассоциированной ЯБ: эрадикационная терапия (ИПН 2 раза в сутки + Кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки + Амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки)

Экспертиза нетрудоспособности: Пациент нетрудоспособен.

Явка: к терапевту через 14 дней с результатами анализов и ЭГДС для оценки эффективности терапии и коррекции дозировок. Пациент направлен на консультацию к врачу гастроэнтерологу.

1.20 Сделайте запись в «Медицинской карте» амбулаторного пациента с клиническими проявлениями ЖДА, при его первичном обращении к врачу-терапевту участковому. Сформулируйте диагноз. Определите тактику ведения пациента. Назначьте необходимое обследование. Дайте рекомендации по лечению. Проведите экспертизу нетрудоспособности.

ФИО: Иванов Иван Иванович

Возраст и пол: 58 лет, мужской

Место работы: ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ», водитель

Жалобы:

На общую слабость, бледность, головную боль, быструю утомляемость, периодические головокружения

Анамнез заболевания:

Считает себя больным в течение последнего месяца, когда заметил проявление немотивированной слабости и бледности. Связывает свое состояние с неполноценным питанием. Отмечает, что в последние полгода стал часто употреблять слабительные средства из-за запоров.

Анамнез жизни:

перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Операции, травмы отрицает. Наследственность неотягощена. Питание нерегулярное.

Эпидемиологический анамнез:

Контакт с инфекционными больными отрицает. За пределы РФ за последние 2 года не выезжал.

Аллергологический анамнез:

Аллергию на лекарственные препараты, пищевые продукты отрицает.

Физикальный осмотр:

Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, в месте и времени ориентирован, положение активное, контактен. Телосложение: конституциональный тип гиперстенический, рост 172 см, масса тела 95 кг (ИМТ 32). Температура тела 36,6°C. Кожный покров бледные, сухие. Ногти и видимые слизистые бледные, ногти ломкие. Углы рта – трещины. Щитовидная железа не пальпируется. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Костно-суставная система без видимой патологии. Движения в суставах в полном объеме. Опорно-двигательный аппарат без особенностей, активные/пассивные движения сохранены. Деформации, отеков нет. Пальпация остистых отростков позвонков и паравертебральных точек безболезненна. Симптом Ласега отрицательный. Сыпь, рубцы отсутствуют.

Дыхательная система:

Дыхание через нос свободное. Грудная клетка симметрична, правильной формы. Пальпация безболезненна, грудная клетка эластичная. Сравнительная перкуссия: перкуторный звук ясный легочный над всей поверхностью ГК. При аускультации дыхание везикулярное, патологических шумов, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Крепитация и шум трения плевры не выслушиваются.

ССС:

Область сердца не изменена. Пульс 78 уд/мин удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный. При перкуссии границы относительной сердечной тупости не расширены. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 78 ударов в минуту, АД 110/70 мм. рт. ст. (правая и левая руки).

Пищеварительная система:

Язык сухой, слабо обложен белым налетом. Живот мягкий,

безболезненный во всех отделах. Симптом раздражения брюшины отсутствует. При аускультации прослушивается периодическая перистальтика кишечника, шум трения брюшины и сосудистые шумы не выслушиваются. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз в день. Визуально область проекции почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Нервная система:

Психоневрологический статус: Сознание ясное. Больной контактен, адекватен, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Речь не нарушена. Менингеальные симптомы отсутствуют. Чувствительность не нарушена.

Предварительный диагноз:

Основной диагноз: Железодефицитная анемия, средней степени тяжести, гипохромная, регенераторная, микроцитарная. Сидеропенический синдром.

Обследование:

1. Лабораторные исследования:

- клинический анализ крови: эритроциты, гемоглобин, лейкоцитарная формула, тромбоциты, средняя концентрация гемоглобина в эритроците
- биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, общий билирубин + фракции, ГГТ, ЩФ, альбумин, креатинин, сывороточное железо, трансферрин, ОЖСС
- липидограмма: общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды
- общий анализ мочи
- анализ кала на скрытую кровь

2. Инструментальные исследования:

- ЭГДС
- колоноскопия
- УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
- ЭКГ
- рентгенография ОГК

Лечение:

1. Режим амбулаторный

- Диета: полноценное сбалансированное питание с обязательным включением продуктов, богатых гемовым железом. Сочетать мясные блюда с овощами и фруктами.

2. Сорбифер Дурулес 1 таб в сут (концентрация гемоглобина более 70 г/л)

Экспертиза нетрудоспособности: Пациент нетрудоспособен.

Явка: к терапевту через 14 дней с результатами анализов и ЭГДС для оценки эффективности терапии и коррекции дозировок.



Задачи

2.1 Клиническая ситуация: пациентка, 49 лет. Обратилась с целью проведения диспансеризации. Не курит, наличие хронических неинфекционных заболеваний отрицает. Наследственность: инсульт у матери в возрасте 58 лет. По результатам проведенной диспансеризации: АД 150/92 мм рт. ст., масса тела 69 кг, рост 159 см, ОТ 98 см, общий холестерин – 6,2 ммоль/л, глюкоза – 6,0 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение гликемии натощак, наличие абдоминального ожирения, избыточная масса тела (27,3 кг/м²).

индивидуальные (немодифицируемые): семейный анамнез развития ССЗ у женщин <65 лет (инсульт у матери в 58 лет).

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

низкий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД ≤ 130 , не < 120 мм рт. ст., ДАД < 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ < 80 см у женщин
4. Общий ХС $< 4,9$ ммоль/л
5. Глюкоза плазмы натощак не выше 6,1 ммоль/л

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до < 5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; ограничение потребления быстрых углеводов
4. Контроль массы тела
5. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Периндоприл+ Амлодипин 5+ 5 мг $\frac{1}{2}$ таб/сут или Периндоприл+Индапамид 5+1,25 мг/сут
2. Аторвастатин 20 мг/сут (необходимы результаты липидного профиля (ЛПНП, ЛПВП, ТГ), АЛТ, АСТ)

2.2 Клиническая ситуация: пациент, 64 года. Обратился по результатам диспансеризации. Предъявляет жалобы на боль давящего характера за грудиной, возникающую при ходьбе на 300-400 м, прекращается в течение 2 минут в покое. Боль беспокоит около 8 недель. В анамнезе гипертоническая болезнь в течение 12 лет, курит 10 сигарет в день на протяжении 20 лет. Регулярно принимает эналаприл 5 мг, аторвастатин 20 мг. АД 164/80 мм рт. ст., масса тела 90 кг, рост 179 см, ОХ 6,0 ммоль/л, ЛПНП 2,6 ммоль/л, ЛПВП – 1,1 ммоль/л. ЭКГ в покое – без ишемических изменений.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

образ жизни (модифицируемые): курение

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, избыточная масса тела (ИМТ 28,1 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): возраст (≥ 55 лет у мужчин, в данном случае 64 года), мужской пол.

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД ≤ 130 , не < 120 мм рт. ст., ДАД < 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ < 94 см у мужчин
4. ЛПНП $< 1,4$ ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. Полный отказ от курения

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Отказ от курения
2. Ограничение потребления соли до < 5 г в сутки
3. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
4. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса
5. Контроль массы тела
6. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Необходимо дообследование пациента с ИБС для коррекции терапии (предварительный диагноз - стабильная стенокардия напряжения), высокая предтестовая вероятность
2. В настоящий момент назначены: коррекция АГТ: интенсификация терапии — иАПФ+БКК— Периндоприл 4мг+ Амлодипин 5 мг; Коррекция гиполипидемической терапии: целевой уровень ЛПНП не достигнут, необходимо увеличение дозы Аторвастатина до 40 мг (под контролем АЛТ, АСТ)

2.3 Клиническая ситуация: пациент, 52 года. Обратился по результатам диспансеризации. Курит 15 сигарет в день в течение 25 лет. Хронические заболевания отрицает. Наследственность: инфаркт миокарда у отца в 54 года. Объективно: АД 148/94 мм рт. ст., масса тела 96, рост 176 см, ИМТ 31 кг/м², ОТ 108 см. Лабораторно: общий холестерин – 6,8 ммоль/л, ЛПНП – 4,3 ммоль/л, ЛПВП – 1,5 ммоль/л, глюкоза – 5,9 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

образ жизни (модифицируемые): курение

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение гликемии натощак, наличие абдоминального ожирения, ожирение 1 степени (ИМТ 31 кг/м²).

индивидуальные (немодифицируемые): мужской пол, семейный анамнез развития ССЗ у мужчин до 55 лет (инфаркт миокарда у отца в 54 года).

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД $\leq$ 130, не $<$ 120 мм рт. ст., ДАД $<$ 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ $<$ 94 см у мужчин
4. ЛПНП $<$ 1,4 ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. Глюкоза плазмы натощак не выше 6,1 ммоль/л
6. Полный отказ от курения

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Отказ от курения
2. Ограничение потребления соли до $<$ 5 г в сутки
3. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
4. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; снизить потребление быстрых углеводов
5. Контроль массы тела
6. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Периндоприл+ Амлодипин 5+ 5 мг $\frac{1}{2}$ таб/сут или Периндоприл+Индапамид 5+1,25 мг/сут
2. Розувастатин 20 мг/сут (под контролем АЛТ, АСТ)

2.4 Клиническая ситуация: пациентка, 46 лет. Жалоб не предъявляет, обратилась в рамках диспансеризации. Не курит, ведет малоподвижный образ жизни. Менопауза 1 год назад. АД 142/80 мм рт. ст., масса тела 71 кг, рост 162 см, ОТ 92 см. Общий холестерин – 5.9 ммоль/л, ЛПНП – 3,7 ммоль/л, ЛПВП – 1,0, глюкоза – 6,3 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

Образ жизни (модифицируемые): низкая физическая активность

Метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение гликемии натощак, наличие абдоминального ожирения, избыточная масса тела (ИМТ 27,1 кг/м²).

Индивидуальные (немодифицируемые): менопауза

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД $\leq$ 130, не $<$ 120 мм рт. ст., ДАД 70-79 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ $<$ 80 см у женщин
4. Глюкоза плазмы натощак не выше 6,1 ммоль/л
5. ЛПНП $<$ 1,8 ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
6. ЛВП $>$ 1,2 ммоль/л у женщин
7. Подбор оптимального режима физической активности, повышение уровня переносимости физической нагрузки

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до $<$ 5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; снизить потребление быстрых углеводов
4. Контроль массы тела
5. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Периндоприл 5 мг/сут
2. Розувастатин 10 мг/сут (под контролем АЛТ, АСТ)

2.5 Клиническая ситуация: пациентка, 56 лет. Курит 10 сигарет в день 20 лет.

Наследственность: сахарный диабет 2 типа у матери. АД 128/86 мм рт. ст., масса тела 85 кг, рост 160 см, ОТ 104 см. Общий холестерин – 6,0 ммоль/л, ЛПНП – 3,9 ммоль/л, ЛВП – 1,6 ммоль/л, глюкоза – 7,2 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

образ жизни (модифицируемые): курение

метаболические (модифицируемые): дислипидемия, глюкоза плазмы натощак 7,2 ммоль/л (вероятность сахарного диабета с учетом наследственности), наличие абдоминального ожирения, ожирение 1 степени (ИМТ 33,2 кг/м²)

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. ИМТ 20-24,9 кг/м²
2. ОТ <80 см у женщин
3. ЛПНП <1,4 ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
4. Целевой уровень HbA1c <7,0 % (при подтвержденном СД, необходимы данные лабораторных исследований)
5. Полный отказ от курения

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Отказ от курения
2. Ограничение потребления соли до <5 г в сутки
3. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
4. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; ограничение потребления быстрых углеводов
5. Контроль массы тела
6. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Розувастатин 20 мг/сут (под контролем АЛТ, АСТ)

2.6 Клиническая ситуация: пациент, 45 лет. Не курит. Наследственность отягощена: инсульт у отца в 52 года. АД 155/100 мм рт. ст., масса тела 94 кг, рост 179 см, ОТ 100 см. Общий холестерин – 7,0 ммоль/л, глюкоза – 6,2 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение гликемии натощак, наличие абдоминального ожирения, избыточная масса тела (ИМТ 29,3 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): мужской пол, семейный анамнез развития ССЗ у мужчин до 55 лет (инсульт у отца в 52 года).

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

умеренный сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД $\leq$ 130, не $<$ 120 мм рт. ст., ДАД $<$ 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ $<$ 94 см у мужчин
4. Общий ХС $<$ 4,9 ммоль/л
5. Глюкоза плазмы натощак не выше 6,1 ммоль/л

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до $<$ 5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; ограничение потребления быстрых углеводов
4. Контроль массы тела
5. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Периндоприл+ Амлодипин 5+ 5 мг $\frac{1}{2}$ таб/сут или или Периндоприл+Индапамид 5+1,25 мг/сут
2. Аторвастатин 20 мг/сут (необходимы результаты липидного профиля (ЛПНП, ЛПВП, ТГ), АЛТ, АСТ)

2.7 Клиническая ситуация: пациентка, 50 лет, учитель в школе. Жалоб нет, обратилась по результатам диспансеризации. Наличие вредных привычек отрицает, регулярно занимается спортом (йога, ходьба). АД 148/90 мм рт. ст., масса тела 60 кг, рост 164 см, ОТ 72 см. Общий холестерин – 7,0 ммоль/л, ЛПВП – 2,1 ммоль/л, ЛПНП – 3,0 ммоль/л, глюкоза – 6,2 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

образ жизни (модифицируемые): возможно наличие психозмоционального стресса в связи с работой

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение гликемии натощак

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД ≤ 130 , не < 120 мм рт. ст., ДАД < 80 мм рт. ст.
2. ЛПНП $< 1,8$ ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
3. Глюкоза плазмы натощак не выше 6,1 ммоль/л
4. Минимизация стресса

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до < 5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Периндоприл+ Амлодипин 5+ 5 мг $\frac{1}{2}$ таб/сут или Периндоприл+Индапамид 5+1,25 мг/сут
2. Розувастатин 10 мг/сут (под контролем АЛТ, АСТ)

2.8 Клиническая ситуация: пациент, 58 лет. 2 года назад перенес ишемический инсульт. Курение прекратил 1 год назад. АД 150/95 мм рт. ст., масса тела 80 кг, рост 172 см, ОТ 101 см. Общий холестерин – 6,1 ммоль/л, ЛПНП – 3,8 ммоль/л, ЛПВП – 1,8, глюкоза – 6,0 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение гликемии натощак, наличие абдоминального ожирения, избыточная масса тела (ИМТ 27 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): возраст ≥ 55 лет у мужчин, мужской пол

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД ≤ 130 не < 120 мм рт. ст., ДАД < 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ < 94 см у мужчин
4. ЛПНП $< 1,4$ ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. Глюкоза плазмы натощак не выше 6,1 ммоль/л

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до < 5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; ограничение потребления быстрых углеводов
4. Контроль массы тела
5. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Периндоприл 5 мг/сут
2. Амлодипин 5 мг/сут
3. Розувастатин 20 мг/сут (под контролем АЛТ, АСТ)
4. Аспирин 100 мг/сут

2.9 Клиническая ситуация: пациент, 72 года. В анамнезе гипертоническая болезнь, пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Регулярно принимает лозартан + гидрохлортиазид 50+12,5 мг 1 раз в день, амлодипин 5 мг 1 раз в день, ривароксабан 20 мг 1 раз в день, аторвастатин 20 мг 1 раз в день. Не курит, регулярно занимается физической активностью – 3 раза в неделю умеренной интенсивности 60 минут в день. АД 128/74 мм рт. ст., масса тела 80 кг, рост 174 см, ОТ 96 см. Общий холестерин – 5,6 ммоль/л, ЛПНП – 2,6 ммоль/л, ЛПВП – 1,6 ммоль/л, глюкоза – 5,2 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

метаболические (модифицируемые): дислипидемия, наличие абдоминального ожирения, избыточная масса тела (ИМТ 26,4 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): возраст ≥ 55 лет у мужчин, мужской пол

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. ИМТ 20-24,9 кг/м²
2. ОТ <94 см у мужчин
3. ЛПНП <1,4 ммоль/л или на 50% и более от исходного значения

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до <5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; ограничение потребления быстрых углеводов
4. Контроль массы тела
5. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Коррекция гиполипидемической терапии: целевой уровень ЛПНП не достигнут, необходимо увеличение дозы Аторвастатина до 40 мг (под контролем АЛТ, АСТ)

2.10 Клиническая ситуация: пациентка, 78 лет. В анамнезе сахарный диабет в течение 3 лет, получает метформин. Не курит. АД 140/88 мм рт. ст., масса тела 80 кг, рост 157 см, ОТ 102 см. Общий холестерин – 6,4 ммоль/л, ЛПНП – 4,2 ммоль/л, ЛПВП – 1 ммоль/л, глюкоза натощак – 8,4 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет в анамнезе, наличие абдоминального ожирения, ожирение (ИМТ 32,5 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): возраст ≥65 лет у женщин (в данном случае 78 лет)

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД 130-139 мм рт. ст., ДАД <80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ <80 см у женщин
4. ЛПНП <1,4 ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. ЛВП > 1,2 ммоль/л у женщин
6. Препрандиальный уровень глюкозы у функционально независимых пациентов <8 ммоль/л
7. Целевой уровень HbA1c <8.0%

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до <5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; ограничение потребления быстрых углеводов
4. Контроль массы тела
5. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Периндоприл+ Амлодипин 5+ 5 мг ½ таб/сут или Периндоприл+Индапамид 5+1,25 мг/сут
2. Аторвастатин 40 мг/сут (под контролем АЛТ, АСТ)

2.11 Клиническая ситуация: пациент, 56 лет. Жалобы: утомляемость, одышка при минимальной нагрузке, отеки голеней к вечеру, тяжесть в правом подреберье. Курит до пачки сигарет в день. Наследственность: сахарный диабет 2 типа у матери. В анамнезе холецистэктомия. АД 146/86 мм рт. ст., масса тела 98 кг, рост 175 см, ОТ 103 см. Общий холестерин – 6,0 ммоль/л, ЛПНП – 3,5 ммоль/л, ЛВП – 0,8 ммоль/л, триглицериды – 1,9 ммоль/л, глюкоза – 6,2 ммоль/л, креатинин 102 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

образ жизни (модифицируемые): курение

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение гликемии натощак, наличие абдоминального ожирения, ожирение (ИМТ 32 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): возраст ≥ 55 лет у мужчин, мужской пол

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: АД: САД ≤ 130 , не < 120 мм рт. ст., ДАД < 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ < 94 см у мужчин
4. ЛПНП $< 1,4$ ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. ЛВП $> 1,0$ ммоль/л у мужчин
6. Триглицериды $< 1,7$ ммоль/л
7. Глюкоза плазмы натощак не выше 6,1 ммоль/л
8. Полный отказ от курения

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Отказ от курения
2. Ограничение потребления соли до < 5 г в сутки
3. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
4. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса
5. Контроль массы тела
6. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Необходимо дообследование пациента для коррекции терапии
2. В настоящий момент назначены: АГТ — иАПФ+БКК — Периндоприл 4мг+ Амлодипин 5 мг; Гиполипидемический терапии: Розувастатин 20 мг (под контролем АЛТ, АСТ)

2.12 Клиническая ситуация: пациент, 62 года. Предъявляет жалобы на одышку, возникающую при ходьбе на 300-400 м, боль в коленных суставах. В анамнезе гипертоническая болезнь в течение 12 лет, употребляет алкоголь в умеренном количестве. Терапию принимает нерегулярно. АД 154/90 мм рт. ст., масса тела 98 кг, рост 178 см, ОТ – 100 см, ОХ 6,0 ммоль/л, ЛПНП 2,8 ммоль/л, ЛВП – 1,0 ммоль/л. ЭКГ в покое – признаки ГЛЖ.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

образ жизни (модифицируемые): употребление алкоголя

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, наличие абдоминального ожирения, ожирение (ИМТ 30,9 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): возраст ≥ 55 лет у мужчин, мужской пол

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: АД: САД ≤ 130 , не < 120 мм рт. ст., ДАД < 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ < 94 см у мужчин
4. ЛПНП $< 1,4$ ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. ЛВП $> 1,0$ ммоль/л у мужчин

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до < 5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; органические потребления быстрых углеводов
4. Контроль массы тела
5. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Необходимо дообследование пациента для коррекции терапии
2. В настоящий момент назначены: АГТ — иАПФ+БКК— Периндоприл 4мг+ Амлодипин 5 мг; Гиполипидемический терапии: Розувастатин 20 мг (под контролем АЛТ, АСТ); Кетопрофен 2,5% гель для наружного применения, нанести тонким слоем на кожу 1-2 раза в сутки, втирать

2.13 Клиническая ситуация: пациент, 50 года. Предъявляет жалобы на боль за грудиной при ходьбе на 300-400 м. В анамнезе стабильная стенокардия напряжения, гипертоническая болезнь, употребляет алкоголь в умеренном количестве, бросил курить 3 месяца назад. Терапию принимает нерегулярно. АД 144/80 мм рт. ст., масса тела 100 кг, рост 180 см, ОТ – 98 см, ОХ 5,0 ммоль/л, ЛПНП 1,9 ммоль/л, ЛПВП – 1,0 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

образ жизни (модифицируемые): употребление алкоголя, недавний отказ от курения

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, наличие абдоминального ожирения, ожирение (ИМТ 30,9 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): мужской пол

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: АД: САД $\leq$ 130, не $<$ 120 мм рт. ст., ДАД $<$ 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ $<$ 94 см у мужчин
4. ЛПНП $<$ 1,4 ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. ЛВП $>$ 1,0 ммоль/л у мужчин

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до $<$ 5 г в сутки
2. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
3. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; ограничить потребление быстрых углеводов
4. Контроль массы тела
5. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Аспирин 100 мг/сут
2. Розувастатин 20 мг/сут (под контролем АЛТ, АСТ)
3. Эналаприл 10 мг/сут
4. Бисопролол 2,5 мг/сут, коррекция дозы в зависимости от ЧСС и уровня АД.
5. При болях в сердце - нитроспрей (при отсутствии эффекта повторить через 5 мин, но не более 3 раз подряд).

2.14 Клиническая ситуация: пациент, 72 года. Предъявляет жалобы на одышку, возникающую при ходьбе на 500 м, боль в коленных суставах, отёки голени. В анамнезе гипертоническая болезнь, СД 2 типа, ХБП 3а ст, вредные привычки отрицает. АД 150/80 мм рт. ст., масса тела 85 кг, рост 174 см, ОТ – 95 см, ОХ 5,0

ммоль/л, ЛПНП 1,8 ммоль/л, ЛПВП – 1,1 ммоль/л, триглицериды – 1,9 ммоль/л, креатинин 109 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет 2 типа, наличие абдоминального ожирения, избыточная масса тела (ИМТ 28,1 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): возраст ≥ 55 лет у мужчин, мужской пол

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: САД 130-139 мм рт. ст., ДАД < 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ < 94 см у мужчин
4. ЛПНП $< 1,4$ ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. Триглицериды $< 1,7$ ммоль/л
6. Целевой уровень HbA1c $< 8\%$

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Ограничение потребления соли до < 5 г в сутки
2. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; ограничить потребление быстрых углеводов
3. Контроль массы тела
4. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

1. Необходимо дообследование пациента для коррекции терапии
2. В настоящий момент назначены: АГТ — иАПФ+БКК— Периндоприл 4мг+ Амлодипин 5 мг; Гиполипидемический терапии: Розувастатин 20 мг (под контролем АЛТ, АСТ); Кетопрофен 2,5% гель для наружного применения, нанести тонким слоем на кожу 1-2 раза в сутки, втирать

2.15 Клиническая ситуация: пациент, 64 лет. Водитель. Жалобы: одышка при минимальной нагрузке, тяжесть в правом подреберье. Курит до пачки сигарет в день. Наследственность: ИМ в возрасте 58 лет у отца. В анамнезе г. АД 150/90 мм

рт. ст., масса тела 108 кг, рост 180 см, ОТ 104 см. Общий холестерин – 5,4 ммоль/л, ЛПНП – 3,4 ммоль/л, ЛПВП – 1,0 ммоль/л, триглицериды – 1,8 ммоль/л, глюкоза – 6,9 ммоль/л, креатинин 97 ммоль/л.

Задания:

1. Определите факторы риска у данного пациента

образ жизни (модифицируемые): курение, низкая физическая активность в связи с работой

метаболические (модифицируемые): артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение гликемии натощак, наличие абдоминального ожирения, ожирение (ИМТ 33,3 кг/м²)

индивидуальные (немодифицируемые): возраст ≥ 55 лет у мужчин, мужской пол, инфаркт миокарда у отца в 58 лет

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск

очень высокий сердечно-сосудистый риск

3. Определите целевые значения основных факторов риска

1. АД: АД: САД ≤ 130 , не < 120 мм рт. ст., ДАД < 80 мм рт. ст.
2. ИМТ 20-24,9 кг/м²
3. ОТ < 94 см у мужчин
4. ЛПНП $< 1,4$ ммоль/л или на 50% и более от исходного значения
5. Триглицериды $< 1,7$ ммоль/л
6. ЛПВП $> 1,0$ ммоль/л у мужчин
7. Глюкоза плазмы натощак не выше 6,1 ммоль/л
8. Полный отказ от курения
9. Подбор оптимального режима физической активности, повышение уровня переносимости физической нагрузки

4. Сформулируйте программу модификации образа жизни.

1. Отказ от курения
2. Ограничение потребления соли до < 5 г в сутки
3. Ограничение потребления алкоголя в неделю до 7 единиц, избегать хронического употребления алкоголя
4. Увеличение потребления овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, ненасыщенных жирных кислот (оливкового масла); потребление молочных продуктов с низким содержанием жира; низкое потребление красного мяса; уменьшение потребления быстрых углеводов
5. Контроль массы тела
6. Регулярные аэробные физические нагрузки (не менее 30 минут умеренной динамической физической активности в течение 5-7 дней в неделю)

5. При необходимости, назначьте (скорректируйте) медикаментозную терапию

3. Необходимо дообследование пациента для коррекции терапии
4. В настоящий момент назначены: АГТ — иАПФ+БКК— Периндоприл 4мг+ Амлодипин 5 мг; Гиполипидемический терапии: Розувастатин 20 мг (под контролем АЛТ, АСТ)

Успешной сдачи!!!

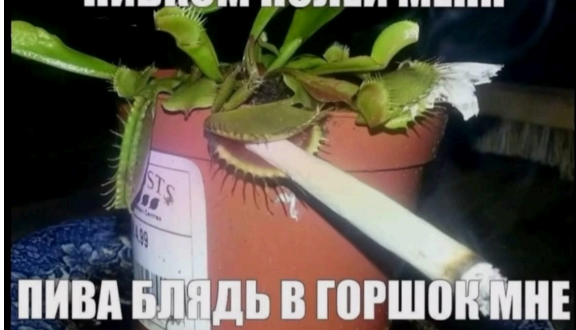


Я РЕАЛЬНЫЙ НЕПОСЕДА



А НЕ ТИХИЙ САСУНОК

ПИВКОМ ПОЛЕЙ МЕНЯ



ПИВА БЛЯДЬ В ГОРШОК МНЕ

**А ВЕДЬ МОЛЕКУЛЫ
ИЗ КОТОРЫХ Я
СОСТОЮ ОНИ ВСЕ
ДАЛБАЕБЫ**

